# G6 — Fièvre, frissons, hyperthermie · Entraînement Type A · Réflexe SSP · v1

LOT_006 audité · Phase A + Phase B (DX.1–15) · 100 questions Type A, 5 options · examen fédéral CH (CK) · 60 EX · 24 AP · 16 SPE

## 🧭 Carte mentale G6 · 60 secondes avant de répondre

**EX Examen** — vignette type examen fédéral CK : décision clinique, 5 options. Priorité absolue.

**AP Approfondissement** — mécanismes, nuances, raisonnement enrichi. Texte en bleu.

**SPE · spécialité Spécialiste** — niveau spécialité. Touchez 🔥 quand une question vous passionne : le score dira quelle spécialité vous exalte.

Version papier : répondez d'abord ; le corrigé commenté est en annexe, après la dernière question. Version écran : choisissez une option → elle se marque **juste** ou **fausse**. Le commentaire ne s'ouvre **que** si vous touchez 💡.

**Les 3 questions réflexes devant une fièvre**

1. **Drapeau rouge ?** Hypotension, confusion ou polypnée ; céphalée, raideur, purpura ; > 40 °C avec confusion après chaleur ou effort ; chimiothérapie ; retour de zone palustre ; prothèse valvulaire, souffle nouveau, drogues injectées.
2. **Fièvre ou hyperthermie ?** Consigne relevée (cytokines → COX-2 → PGE2) ou consigne normale (chaleur, effort) : l'antipyrétique n'agit que sur la première.
3. **Depuis quand, où est le foyer ?** Poumon, urine, peau, digestif ; voyage, médicaments des 8 dernières semaines ; **≥ 3 semaines** avec bilan de base négatif : démarche du FUO, sans antibiotique ni corticoïde d'épreuve si stable.

### 🫁 Foyers fréquents

- Opacité nouvelle = pneumonie ; score de gravité → domicile ou hôpital (DX.1)
- Fièvre + lombalgie + culture = pyélonéphrite ; pas de ciprofloxacine si grossesse (DX.2)
- Douleur disproportionnée → chirurgien (DX.3)
- Réhydratation orale ; pas de lopéramide si sang ou < 6 ans (DX.10)

### ✈️ Retour de voyage

- Test rapide + frottis le jour même ; répéter à 12–24 h (DX.6)
- Grave → artésunate i.v. ; Riamet® contre-indiqué
- Dengue : PCR/NS1 ≤ 7 j, paracétamol, pas d'AINS ; défervescence = phase critique (DX.7)

### ⏳ FUO

- ≥ 3 sem, 38,3 °C × 2, immunité normale, bilan de base négatif (DX.4)
- VS/CRP élevées → FDG-TEP-TDM → biopsie (DX.8)
- > 50 ans, céphalée et vue → prednisone le jour même (DX.5)

### 🤧 Viral

- Grippe à risque → oseltamivir 75 mg 2×/j 5 j, dans les 36 h (DX.9)
- Fièvre qui repart → radiographie (surinfection)
- Paracétamol ≤ 4 g/j ; pas d'ibuprofène au 3e trimestre

## 🚩 Ordre d'exclusion

1. E1 Coup de chaleur (DX.15)
2. E2 Sepsis (DX.11)
3. E3 Méningite, méningococcie (DX.12)
4. E4 Neutropénie fébrile (DX.14)
5. E5 Paludisme à P. falciparum (DX.6)
6. E6 Endocardite (DX.13)

**Choc septique : mortalité hospitalière > 40 % ; méningocoque invasif : létalité 7,3 % en Suisse ; FUO néoplasique : 38 % à 6 mois.**

# ① Raisonner · 31 Q · avant de nommer le diagnostic

Devant une fièvre : drapeau rouge d'abord (sepsis, méningite, coup de chaleur, neutropénie, paludisme, endocardite), puis le foyer, puis le terrain et l'exposition. Un antipyrétique ne ferme aucune branche dangereuse.

**Q1** **EX** **DX.11 · fébrile et hypotendu** Prise en charge · urgences

Un homme de 71 ans est amené pour fièvre à 39,2 °C et frissons depuis la veille. Il est confus. FC 118/min, PA 88/52 mmHg, FR 26/min, SpO2 92 %. Pas de purpura.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Hémocultures, puis antibiotique i.v. dans l'heure
- **B** Attendre le lactate avant de décider de l'antibiotique
- **C** Rechercher le foyer par scanner, puis traiter
- **D** Paracétamol 1 g i.v. et réévaluation à 1 heure
- **E** Antibiotique oral et contrôle le lendemain

**Q2** **EX** **DX.11 · remplissage** Prise en charge · urgences

Une femme de 68 ans, 60 kg, est traitée pour un sepsis d'origine urinaire. Les hémocultures sont prélevées et la ceftriaxone est en cours. PA 82/48 mmHg, lactate 4,2 mmol/L.

**Quel remplissage est le plus approprié ?**

- **A** Glucose 5 % 500 mL sur 6 heures
- **B** Cristalloïde balancé ≥ 30 mL/kg en 3 h
- **C** Aucun soluté avant de débuter la noradrénaline
- **D** Albumine 20 % en première intention
- **E** NaCl 0,9 % 250 mL en 24 heures

**Q3** **EX** **DX.11 · PAM basse** Prise en charge · urgences

Un homme de 75 ans en sepsis pulmonaire a reçu 30 mL/kg de cristalloïde et l'antibiotique. Sa PA reste à 80/45 mmHg (PAM 57 mmHg). Lactate 3,8 mmol/L.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Nouveau bolus de 3 litres en 1 heure
- **B** Hydrocortisone avant tout vasopresseur
- **C** Dobutamine en première ligne
- **D** Noradrénaline pour une PAM ≥ 65 mmHg
- **E** Attendre le résultat des hémocultures

**Q4** **EX** **DX.12 vs DX.11 · purpura fébrile** Prise en charge · domicile

Une étudiante de 19 ans a 40 °C, des céphalées et des vomissements depuis 6 heures. Le médecin de garde découvre des taches violacées des jambes qui ne s'effacent pas à la pression. PA 96/60 mmHg.

**Quelle est la conduite immédiate la plus appropriée ?**

- **A** Ponction lombaire avant tout antibiotique
- **B** Scanner cérébral, puis antibiotique
- **C** Paracétamol et contrôle dans 6 heures
- **D** Prélever une sérologie et attendre le résultat
- **E** Ceftriaxone i.v. immédiate, puis transfert

**Q5** **EX** **DX.12 · conscient, sans déficit** Prise en charge · urgences

Un homme de 34 ans consulte pour céphalée intense, fièvre à 39,4 °C et raideur de nuque depuis 12 heures. Glasgow 15, aucun déficit focal, pas de crise, pas de purpura. Les hémocultures sont prélevées.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Scanner cérébral avant toute ponction
- **B** Ponction lombaire, puis dexaméthasone et antibiotique
- **C** Aciclovir seul en attendant le LCR
- **D** Antibiotique oral à domicile et contrôle clinique à 24 heures
- **E** IRM cérébrale programmée dans la semaine

**Q6** **EX** **DX.12 · conscience altérée** Prise en charge · urgences

Une femme de 45 ans est amenée fébrile à 39,8 °C, avec raideur de nuque. Glasgow 9. Elle a convulsé dans l'ambulance. Les hémocultures viennent d'être prélevées.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Scanner, puis décision de l'antibiotique
- **B** Ponction lombaire immédiate, sans imagerie préalable
- **C** EEG, puis traitement selon le tracé
- **D** Dexaméthasone et antibiotique, puis scanner
- **E** Dexaméthasone seule en attendant le LCR

**Q7** **EX** **DX.15 · coureur confus** Prise en charge · terrain

Un coureur de 28 ans s'effondre au 18e kilomètre d'un semi-marathon par 31 °C. Il est agité et désorienté. Sa peau est moite. Température rectale 41,2 °C.

**Quel est le premier geste le plus approprié ?**

- **A** Paracétamol 1 g i.v.
- **B** Bilan sanguin complet avant tout refroidissement
- **C** Immersion du corps en eau froide
- **D** Boisson sucrée et repos à l'ombre
- **E** Scanner cérébral pour la confusion

**Q8** **EX** **DX.15 · personne âgée en canicule** Prise en charge · domicile

Une femme de 86 ans est trouvée somnolente dans son appartement surchauffé pendant une canicule. Température rectale 40,8 °C. Aucun foyer infectieux apparent.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Ibuprofène 400 mg et surveillance
- **B** Hémocultures et attente des résultats
- **C** Couverture chauffante pour calmer les frissons ressentis
- **D** Refroidissement actif immédiat et appel du 144
- **E** Hospitalisation programmée le lendemain

**Q9** **EX** **DX.14 · fièvre sous chimiothérapie** Prise en charge · urgences

Une femme de 52 ans sous chimiothérapie pour un cancer du sein (dernière cure il y a 9 jours) a 38,6 °C. Elle se sent bien. PA 124/76 mmHg. Aucun foyer à l'examen.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Paracétamol et contrôle dans 48 heures
- **B** Radiographie de thorax seule
- **C** Formule sanguine et hémocultures en urgence
- **D** Attendre un foyer clinique avant tout bilan
- **E** CRP seule pour décider

**Q10** **EX** **DX.14 · neutrophiles effondrés** Prise en charge · urgences

Un homme de 60 ans traité pour un lymphome a 38,9 °C. Neutrophiles 0,2 G/L. PA 118/70 mmHg, aucun foyer. Les hémocultures sont prélevées.

**Quel traitement est le plus approprié ?**

- **A** Amoxicilline orale et contrôle à 48 heures
- **B** Ceftriaxone i.m. dose unique
- **C** Filgrastim seul
- **D** Pipéracilline-tazobactam i.v. dans l'heure
- **E** Antibiotique après le résultat des hémocultures

**Q11** **EX** **DX.6 · retour d'Afrique** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un ingénieur de 41 ans rentré du Cameroun il y a 10 jours consulte pour fièvre à 39 °C, frissons et céphalées depuis 2 jours. Il a pris une prophylaxie antipaludique. Examen sans foyer.

**Quel examen faut-il demander en premier ?**

- **A** Sérologie de la dengue, à répéter dans deux semaines
- **B** Aucun test grâce à la prophylaxie
- **C** Radiographie de thorax seule
- **D** Test rapide et frottis-goutte épaisse le jour même
- **E** Coproculture et contrôle à 1 semaine

**Q12** **EX** **DX.6 vs DX.7 · frottis négatif** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 29 ans revient du Mali il y a 8 jours et a 39,5 °C avec des frissons. Le test rapide et le frottis sont négatifs. Plaquettes 98 G/L. Elle reste fébrile.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Exclure le paludisme et la renvoyer à domicile
- **B** Artésunate i.v. sans nouveau test
- **C** Corticoïde d'épreuve
- **D** Sérologie palustre dans 3 semaines
- **E** Répéter les tests du paludisme à 12–24 h

**Q13** **EX** **DX.6 · paludisme grave** Prise en charge · urgences

Un homme de 50 ans revenu du Ghana a 40 °C. Il est confus. Frottis : P. falciparum, parasitémie 12 %. Glycémie 3,1 mmol/L, créatinine en hausse.

**Quel traitement est le plus approprié ?**

- **A** Riamet® per os avec un repas gras
- **B** Malarone® 4 comprimés par jour pendant 3 jours
- **C** Artésunate i.v. en soins intensifs
- **D** Hydroxychloroquine 800 mg
- **E** Doxycycline seule

**Q14** **EX** **DX.13 vs DX.11 · fièvre et drogues injectées** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 32 ans qui s'injecte des drogues a de la fièvre à 39 °C depuis 5 jours. Souffle systolique nouveau au bord gauche du sternum. PA 120/70 mmHg.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Antibiotique empirique immédiat sans prélèvement
- **B** Trois paires d'hémocultures avant l'antibiotique
- **C** Échocardiographie seule, sans hémocultures
- **D** Une hémoculture unique, puis attente
- **E** CRP et contrôle à 1 semaine

**Q15** **EX** **DX.13 · ETT négative** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 70 ans porteuse d'une prothèse valvulaire aortique a de la fièvre depuis 10 jours. Deux hémocultures sur trois montrent Staphylococcus aureus. L'échocardiographie transthoracique est normale.

**Quel examen faut-il demander ensuite ?**

- **A** Échocardiographie transœsophagienne
- **B** Aucun : l'ETT normale exclut l'endocardite
- **C** Radiographie de thorax
- **D** Nouvelle ETT dans 6 mois
- **E** Ponction lombaire

**Q16** **EX** **DX.1 · score à 0** Prise en charge · cabinet

Un homme de 45 ans sans antécédent a de la toux, une fièvre à 38,7 °C et des crépitants basaux droits. Radiographie : opacité nouvelle du lobe inférieur droit. Conscience normale, FR 18/min, PA 132/80 mmHg. Il vit avec sa femme.

**Quel traitement est le plus approprié ?**

- **A** Ceftriaxone i.v. en hospitalisation
- **B** Co-amoxicilline 2 × 1 g/j per os, contrôle à 48–72 h
- **C** Oseltamivir seul
- **D** Pas d'antibiotique, réévaluation clinique dans une semaine
- **E** Ciprofloxacine 2 × 500 mg/j

**Q17** **EX** **DX.1 vs DX.11 · pneumonie sévère** Prise en charge · urgences

Une femme de 78 ans a une pneumonie lobaire. Elle est confuse. FR 32/min, PA 86/54 mmHg, urée élevée.

**Quel traitement antibiotique est le plus approprié ?**

- **A** Co-amoxicilline per os à domicile
- **B** Doxycycline 100 mg per os
- **C** Clarithromycine seule per os
- **D** Ceftriaxone et clarithromycine i.v., soins intensifs
- **E** Antibiotique seulement après le résultat de l'antigène urinaire

**Q18** **EX** **DX.2 · pyélonéphrite simple** Prise en charge · cabinet

Une femme de 31 ans, non enceinte, sans antécédent, a 38,9 °C, des brûlures mictionnelles et une douleur lombaire droite. Ébranlement positif. Elle boit et tolère les comprimés. Bandelette : leucocytes et nitrites positifs.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Fosfomycine en dose unique
- **B** Hospitalisation et ceftriaxone i.v. pendant au moins 7 jours
- **C** Uroculture, puis ciprofloxacine 2 × 500 mg/j 7 jours
- **D** Antibiotique sans uroculture préalable
- **E** Scanner abdominal en urgence

**Q19** **SPE · Urologie** **DX.2 vs DX.11 · obstruction et choc** Prise en charge · urgences

Un homme de 66 ans avec un calcul urétéral gauche connu a 39,6 °C, des frissons et une douleur lombaire. PA 84/50 mmHg. L'échographie montre une dilatation des cavités gauches.

**Quelle est la conduite la plus appropriée après les hémocultures ?**

- **A** Ceftriaxone i.v. et drainage urologique urgent
- **B** Ciprofloxacine per os et contrôle à 72 h
- **C** Antalgique et attente de l'expulsion du calcul
- **D** Antibiotique i.v. seul, sans geste urologique
- **E** Lithotripsie programmée dans 2 semaines

**Q20** **EX** **DX.3 · douleur disproportionnée** Prise en charge · urgences

Un homme diabétique de 58 ans a une rougeur de la cuisse apparue hier. La douleur est intense, sans commune mesure avec l'aspect de la peau. Bulles violacées. FC 122/min, PA 94/58 mmHg.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Flucloxacilline per os et contrôle à 48 h
- **B** Avis chirurgical immédiat pour exploration
- **C** Marquer la limite et réévaluer demain
- **D** IRM avant toute décision
- **E** Calculer le LRINEC et opérer seulement s'il est ≥ 6

**Q21** **EX** **DX.4 · FUO stable** Prise en charge · policlinique

Une femme de 48 ans a de la fièvre documentée à 38,5 °C à plusieurs reprises depuis 5 semaines. Anamnèse, examen, laboratoire de base, radiographie du thorax et échographie abdominale sont sans diagnostic. Elle est stable. VIH négatif.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Essai d'amoxicilline-acide clavulanique 10 jours
- **B** Prednisone 40 mg d'épreuve
- **C** Arrêt des investigations et réassurance
- **D** Aucun antibiotique ; poursuivre le bilan
- **E** Antibiothérapie large i.v. en hospitalisation

**Q22** **EX** **DX.4 · FUO et VS élevée** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 63 ans a une FUO depuis 6 semaines. Le bilan de base est négatif. VS 78 mm/h, CRP 64 mg/L. Il est stable.

**Quel examen a le meilleur rendement à ce stade ?**

- **A** FDG-TEP-TDM
- **B** Scanner thoraco-abdominal seul
- **C** Scintigraphie osseuse
- **D** IRM cérébrale
- **E** Répéter l'échographie abdominale

**Q23** **EX** **DX.5 · céphalée et vue** Prise en charge · cabinet

Une femme de 74 ans a une céphalée temporale nouvelle, une claudication de la mâchoire et une baisse de vision de l'œil droit depuis ce matin. Fébricule à 38,1 °C. VS 92 mm/h.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Corticothérapie le jour même, sans attendre la biopsie
- **B** Biopsie de l'artère temporale d'abord, puis traitement selon l'histologie
- **C** AINS et contrôle dans 1 semaine
- **D** TEP au FDG avant de décider
- **E** Antibiotique empirique pour la fièvre

**Q24** **EX** **DX.7 · défervescence** Prise en charge · cabinet

Un homme de 36 ans rentré de Thaïlande a une dengue confirmée par NS1. Au 6e jour, la fièvre tombe et il se dit mieux, mais il a une douleur abdominale intense et vomit à répétition.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Retour à domicile, la fièvre ayant disparu
- **B** Hospitalisation pour surveillance stricte
- **C** Ibuprofène pour la douleur
- **D** Transfusion de plaquettes préventive
- **E** Corticoïde i.v.

**Q25** **EX** **DX.7 vs DX.6 · NS1 positif** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 27 ans rentre du Burkina Faso, où circulent paludisme et dengue. Fièvre à 39,4 °C depuis 3 jours, myalgies, douleur rétro-orbitaire. L'antigène NS1 de la dengue revient positif.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Arrêter toute recherche : la dengue est confirmée
- **B** Sérologie IgG de la dengue
- **C** Ibuprofène et retour à domicile
- **D** Test rapide et frottis du paludisme le jour même
- **E** Corticoïde pour prévenir le choc

**Q26** **EX** **DX.9 · grippe chez un patient à risque** Prise en charge · cabinet

Un homme de 72 ans avec une BPCO a, depuis hier soir, une fièvre brutale à 39 °C, des frissons, une toux et des courbatures. C'est l'épidémie de grippe. SpO2 95 %, auscultation normale. Clairance de la créatinine 80 mL/min.

**Quel traitement est le plus approprié ?**

- **A** Co-amoxicilline 2 × 1 g/j pendant 7 jours
- **B** Oseltamivir 30 mg 1×/j
- **C** Oseltamivir 75 mg 2×/j pendant 5 jours
- **D** Traitement symptomatique seul
- **E** Prednisone 40 mg pendant 5 jours

**Q27** **EX** **DX.9 vs DX.1 · fièvre qui repart** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 67 ans a eu une grippe confirmée il y a 6 jours. Elle allait mieux, mais la fièvre repart à 39 °C avec une toux productive. Crépitants à la base gauche.

**Quel examen faut-il demander ?**

- **A** Nouvelle PCR grippale
- **B** Sérologie grippale
- **C** Radiographie du thorax
- **D** Aucun examen, poursuivre le symptomatique
- **E** Échocardiographie

**Q28** **EX** **DX.10 · déshydratation modérée** Prise en charge · cabinet

Un garçon de 3 ans, 14 kg, a des vomissements et une diarrhée aqueuse depuis 1 jour, dans un contexte d'épidémie à la crèche. Il a soif, urine peu, pli cutané discret. Conscience normale.

**Quel traitement est le plus approprié ?**

- **A** Perfusion i.v. d'emblée à l'hôpital, puis réévaluation
- **B** Réhydratation orale 40–50 mL/kg en 4–6 h
- **C** Lopéramide
- **D** Diète hydrique stricte de 24 heures
- **E** Antibiotique empirique

**Q29** **EX** **DX.10 · diarrhée sanglante fébrile** Prise en charge · cabinet

Un homme de 42 ans a une diarrhée sanglante depuis 2 jours, avec 39,2 °C et des crampes abdominales. Pas de voyage récent. Il boit sans difficulté.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Lopéramide pour réduire les selles
- **B** Coproculture ou PCR, sans lopéramide
- **C** Ondansétron et retour à domicile
- **D** Ciprofloxacine d'emblée sans prélèvement
- **E** Coloscopie en urgence

**Q30** **EX** **DX.8 vs DX.5 · ganglions et fièvre** Prise en charge · policlinique

Un homme de 57 ans a une fièvre à 38,6 °C depuis 4 semaines, des sueurs nocturnes, une perte de 6 kg et des adénopathies cervicales fermes de 2 cm. Il est stable.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Biopsie ganglionnaire
- **B** Prednisone 50 mg d'épreuve
- **C** Antibiotique d'épreuve 2 semaines
- **D** Surveillance à 3 mois
- **E** Dosage de marqueurs tumoraux seuls

**Q31** **EX** **DX.3 · cellulite simple** Prise en charge · cabinet

Une femme de 55 ans a une rougeur chaude, douloureuse et bien limitée de la jambe gauche depuis 2 jours, avec un intertrigo des orteils. 38,4 °C. Pas de douleur disproportionnée. FC 88/min.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Hospitalisation et antibiotique i.v. jusqu'à l'apyrexie complète
- **B** Hémocultures systématiques avant traitement
- **C** Compression et soins cutanés sans antibiotique
- **D** Bêtalactamine orale, limites marquées, contrôle à 48 h
- **E** Exploration chirurgicale

## ② Discriminer · 54 Q · un signe, un examen qui tranche

Les 15 DX du LOT face à face : un signe, un examen qui tranche, une conduite. Les questions AP (bleu) et SPE (violet) sont mêlées aux EX : filtrez par niveau en haut.

**Q32** **EX** **DX.1 vs DX.9 · radiographie normale** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 59 ans a, depuis 24 heures, une fièvre à 39 °C, une toux et une douleur pleurale droite. Crépitants focaux à droite, FR 24/min. La radiographie du thorax initiale ne montre pas d'opacité.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Conclure à une bronchite virale et arrêter
- **B** Spirométrie
- **C** Bronchoscopie en urgence
- **D** Échocardiographie
- **E** TDM thoracique ou nouvelle radiographie

**Q33** **AP** **DX.1 · critère décisif** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 50 ans a une toux fébrile à 38,5 °C depuis 3 jours. CRP 85 mg/L. Crépitants isolés à la base gauche.

**Quel élément pose le diagnostic de pneumonie communautaire ?**

- **A** CRP supérieure à 50 mg/L au premier bilan
- **B** Score CURB-65 à 1
- **C** Opacité nouvelle à la radiographie
- **D** Fièvre de plus de 3 jours
- **E** Crépitants à l'auscultation

**Q34** **SPE · Médecine intensive** **DX.1 · hydrocortisone en soins intensifs** Prise en charge · hôpital

Un homme de 64 ans est admis aux soins intensifs pour une pneumonie communautaire sévère, sous ceftriaxone et clarithromycine. Il nécessite de l'oxygène à haut débit.

**Quel traitement adjuvant a réduit la mortalité à 28 jours dans l'essai CAPE COD ?**

- **A** Hydrocortisone 200 mg/j i.v.
- **B** Dexaméthasone 0,15 mg/kg toutes les 6 heures
- **C** Oseltamivir 75 mg 2×/j
- **D** Filgrastim
- **E** Méthylprednisolone 1 g/j pendant 3 jours

**Q35** **EX** **DX.2 · pyélonéphrite et grossesse** Prise en charge · cabinet

Une femme de 28 ans enceinte de 22 semaines a 39 °C, des frissons et une douleur lombaire droite. Bandelette positive.

**Quelle est la conduite la plus appropriée après l'uroculture ?**

- **A** Ciprofloxacine 2 × 500 mg/j 7 jours
- **B** Lévofloxacine per os
- **C** Hospitalisation et ceftriaxone i.v.
- **D** Fosfomycine en dose unique
- **E** Doxycycline 100 mg/j

**Q36** **EX** **DX.2 · fièvre persistante à 72 h** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 61 ans diabétique est traitée depuis 72 heures pour une pyélonéphrite par ceftriaxone, selon un antibiogramme sensible. Elle reste à 39 °C avec une douleur lombaire.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Échographie ou TDM des voies urinaires
- **B** Changer pour un carbapénème sans imagerie
- **C** Arrêter l'antibiotique
- **D** Ajouter un antipyrétique et attendre
- **E** Répéter seulement la bandelette

**Q37** **EX** **DX.3 vs pseudo-cellulite** Évaluation / diagnostic · EMS

Une résidente d'EMS de 82 ans a les deux jambes rouges, froides et peu douloureuses depuis plusieurs semaines, avec des varices et un œdème. Apyrétique. Leucocytes normaux.

**Quel est le diagnostic le plus probable ?**

- **A** Érysipèle bilatéral
- **B** Fasciite nécrosante
- **C** Endocardite infectieuse
- **D** Thrombose veineuse profonde bilatérale
- **E** Dermite de stase

**Q38** **AP** **DX.3 · LRINEC bas** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 49 ans a une rougeur de l'avant-bras après une piqûre. Il décrit une douleur intense, croissante, disproportionnée. Le score LRINEC calculé est de 4.

**Quelle interprétation du score est correcte ?**

- **A** Un score bas n'exclut pas la fasciite
- **B** Un score < 6 exclut la fasciite
- **C** Le score pose le diagnostic de cellulite
- **D** Le score remplace l'avis chirurgical
- **E** Le score doit être répété avant toute décision

**Q39** **SPE · Infectiologie** **DX.3 · allergie aux bêtalactamines** Prise en charge · cabinet

Une femme de 44 ans a une cellulite non compliquée du mollet. Elle a fait un choc anaphylactique sous amoxicilline.

**Quel antibiotique est le plus approprié ?**

- **A** Clindamycine per os
- **B** Amoxicilline-acide clavulanique
- **C** Flucloxacilline
- **D** Pénicilline V
- **E** Ceftriaxone i.m.

**Q40** **EX** **DX.4 · 10 jours de fièvre** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 39 ans a de la fièvre depuis 10 jours, documentée à 38,6 °C. Il est stable. L'examen ne trouve pas de foyer.

**Quelle affirmation est correcte ?**

- **A** C'est une FUO : demander un FDG-TEP-TDM
- **B** Ce n'est pas encore une FUO
- **C** C'est une FUO : débuter un antibiotique d'épreuve
- **D** C'est une FUO de l'immunodéprimé
- **E** C'est une fièvre factice certaine

**Q41** **AP** **DX.4 · corticothérapie au long cours** Évaluation / diagnostic · policlinique

Une femme de 66 ans sous prednisone 15 mg/j pour une polyarthrite a de la fièvre depuis 4 semaines. Le bilan de base est négatif.

**Pourquoi ne parle-t-on pas de FUO classique ?**

- **A** La durée de la fièvre est inférieure à 3 semaines
- **B** Le bilan de base n'a pas été fait
- **C** La fièvre n'est pas objectivée
- **D** L'âge dépasse 65 ans
- **E** Le corticoïde ≥ 10 mg/j l'immunodéprime

**Q42** **AP** **DX.4 · VS et CRP normales** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 46 ans a une fièvre rapportée depuis 2 mois. Le bilan de base est négatif. VS et CRP sont normales à plusieurs reprises.

**Quelle démarche est la plus appropriée ?**

- **A** FDG-TEP-TDM en urgence, puis biopsie de la cible
- **B** Biopsie médullaire systématique
- **C** Antibiotique d'épreuve 4 semaines
- **D** Objectiver la fièvre devant témoin
- **E** Prednisone d'épreuve

**Q43** **EX** **DX.5 vs DX.8 · pics quotidiens et éruption** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 31 ans a, depuis 5 semaines, des pics fébriles quotidiens à 39,5 °C, une éruption saumonée fugace, des arthralgies et un mal de gorge. Leucocytose. Facteur rhumatoïde et anticorps antinucléaires négatifs.

**Que faut-il faire avant de retenir une maladie de Still ?**

- **A** Rien : les critères de Yamaguchi suffisent
- **B** Biopsie de l'artère temporale
- **C** Débuter un antibiotique d'épreuve
- **D** Doser les IgG de la dengue
- **E** Exclure infection et cancer

**Q44** **EX** **DX.5 · premier examen de l'ACG** Évaluation / diagnostic · policlinique

Un homme de 71 ans a une céphalée temporale nouvelle et une raideur matinale des épaules, sans trouble visuel. CRP 48 mg/L. La prednisone est débutée.

**Quel examen d'imagerie vient en premier ?**

- **A** Angiographie cérébrale par cathétérisme en urgence
- **B** Scanner cérébral sans contraste
- **C** Scintigraphie osseuse
- **D** IRM du rachis cervical
- **E** Échographie des artères temporales et axillaires

**Q45** **AP** **DX.5 · seuils de classification** Mécanismes · policlinique

Une femme de 68 ans est évaluée pour une artérite à cellules géantes. Le rhumatologue applique les critères ACR/EULAR 2022.

**Quels seuils biologiques rapportent 3 points ?**

- **A** CRP ≥ 10 mg/L ou VS ≥ 50 mm/h
- **B** CRP ≥ 100 mg/L ou VS ≥ 100 mm/h
- **C** Ferritine > 1000 µg/L
- **D** Leucocytes > 15 G/L
- **E** Procalcitonine > 0,5 µg/L

**Q46** **SPE · Rhumatologie** **DX.5 · ferritine et cytopénies** Prise en charge · hôpital

Une femme de 35 ans suivie pour une maladie de Still a une fièvre élevée, une bicytopénie et une ferritine très élevée. Elle se dégrade.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Naproxène et contrôle dans 1 semaine
- **B** Soins intensifs, avis hématologique et rhumatologique
- **C** Méthotrexate en urgence
- **D** Transfusion plaquettaire puis retour à domicile sous surveillance
- **E** Biopsie de l'artère temporale

**Q47** **EX** **DX.6 · Riamet® non compliqué** Prise en charge · hôpital

Un homme de 38 ans, 75 kg, a un accès palustre à P. falciparum non compliqué (parasitémie 1 %). Il est conscient et ne vomit pas.

**Quel schéma de Riamet® est correct ?**

- **A** 1 cp par jour pendant 3 jours
- **B** 4 cp à 0 et 8 h, puis 4 cp 2×/j 2 jours, avec des lipides
- **C** 4 cp en dose unique
- **D** 4 cp une fois par jour pendant 3 jours, à jeun, sans lipides
- **E** 2 cp 2×/j pendant 7 jours

**Q48** **AP** **DX.6 · seuil d'hyperparasitémie** Mécanismes · hôpital

Une femme de 45 ans a un P. falciparum avec une parasitémie de 6 %. Elle est consciente, sans hypoglycémie, sans atteinte rénale, sans détresse respiratoire.

**Comment classer cet accès selon l'OMS 2023 ?**

- **A** Hyperparasitémie non compliquée
- **B** Paludisme grave
- **C** Paludisme à P. vivax
- **D** Accès simple à faible parasitémie
- **E** Paludisme cérébral

**Q49** **SPE · Médecine tropicale** **DX.6 · P. vivax** Prise en charge · hôpital

Un homme de 33 ans revenu d'Inde a un accès à P. vivax, traité par Riamet®. Il va mieux.

**Quelle étape reste nécessaire ?**

- **A** Aucune : Riamet® élimine les formes hépatiques
- **B** Doser la G6PD, puis traiter les hypnozoïtes
- **C** Artésunate i.v. 3 jours
- **D** Prophylaxie par Malarone® à vie
- **E** Splénectomie

**Q50** **EX** **DX.7 · antipyrétique** Prise en charge · cabinet

Une femme de 30 ans, 60 kg, a une dengue confirmée sans signe d'alarme. Fièvre à 39 °C et myalgies. Elle boit bien.

**Quel antipyrétique est le plus approprié ?**

- **A** Ibuprofène 400 mg 3×/j
- **B** Acide acétylsalicylique 500 mg
- **C** Paracétamol, 4 g/j au maximum
- **D** Métamizole i.v.
- **E** Naproxène 500 mg 2×/j

**Q51** **EX** **DX.7 · RT-PCR négative au 9e jour** Évaluation / diagnostic · policlinique

Un homme de 40 ans rentré du Brésil a de la fièvre depuis 9 jours, une éruption et des myalgies. Paludisme exclu. La RT-PCR dengue est négative.

**Quel examen faut-il demander ?**

- **A** Aucun : la dengue est exclue
- **B** IgM antidengue
- **C** IgG antidengue sur un seul sérum
- **D** Nouvelle RT-PCR dans 1 semaine
- **E** Antigène NS1 au 15e jour

**Q52** **AP** **DX.7 · pression normale** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 25 ans hospitalisée pour une dengue avec signes d'alarme a une PA à 104/92 mmHg, une FC à 118/min et une recoloration capillaire allongée.

**Quelle interprétation est correcte ?**

- **A** Pression pulsée étroite : choc débutant
- **B** PA normale : pas de choc
- **C** Tachycardie due seulement à la fièvre élevée
- **D** Hypertension réactionnelle
- **E** Signe de guérison

**Q53** **AP** **DX.7 · IgG positives** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un voyageur de 52 ans fébrile depuis 3 jours au retour du Vietnam a des IgG antidengue positives sur un seul sérum. Il avait déjà voyagé en Asie.

**Quelle interprétation est correcte ?**

- **A** Elles confirment une dengue aiguë
- **B** Elles excluent la dengue
- **C** Elles prédisent une dengue sévère
- **D** Elles ne posent pas un diagnostic aigu
- **E** Elles dispensent de tester le paludisme

**Q54** **SPE · Médecine intensive** **DX.7 · choc de dengue** Prise en charge · hôpital

Un homme de 29 ans a une dengue sévère avec choc par fuite plasmatique. Plaquettes 18 G/L, sans saignement actif. Le remplissage par cristalloïde est en cours.

**Quelle mesure est la plus appropriée ?**

- **A** Pas de plaquettes préventives ni de corticoïdes
- **B** Transfusion plaquettaire préventive
- **C** Méthylprednisolone i.v.
- **D** Albumine en première intention
- **E** Remplissage libéral de 6 L de cristalloïde en 2 heures

**Q55** **EX** **DX.8 · captation au TEP** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 68 ans a une FUO. Le FDG-TEP-TDM montre une captation intense d'un ganglion rétropéritonéal.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Chimiothérapie d'emblée
- **B** Conclure à un lymphome et adresser en soins palliatifs
- **C** Biopsie de la zone captante
- **D** Prednisone d'épreuve
- **E** Répéter le TEP dans 6 mois

**Q56** **EX** **DX.8 vs DX.14 · fièvre après chimiothérapie** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 59 ans traitée par chimiothérapie pour une leucémie est fébrile depuis 4 semaines. Neutrophiles 0,3 G/L.

**Comment classer cette situation ?**

- **A** FUO d'origine néoplasique
- **B** FUO idiopathique
- **C** Neutropénie fébrile, pas une FUO
- **D** Fièvre factice
- **E** Maladie inflammatoire non infectieuse

**Q57** **AP** **DX.8 · test au naproxène** Mécanismes · hôpital

Un homme de 64 ans a une FUO stable. Une néoplasie est suspectée, la biopsie est programmée. Le médecin discute un test au naproxène.

**Quelle est la portée de ce test ?**

- **A** Il pose à lui seul le diagnostic de néoplasie
- **B** Il oriente, sans prouver la néoplasie
- **C** Il remplace la biopsie
- **D** Il exclut une infection
- **E** Il guérit la fièvre néoplasique

**Q58** **AP** **DX.8 · pics fébriles élevés** Mécanismes · policlinique

Un étudiant demande quelles néoplasies donnent classiquement des pics fébriles élevés dans la FUO.

**Quelle réponse est correcte ?**

- **A** Myélome multiple
- **B** Syndromes myéloprolifératifs
- **C** Leucémie lymphoïde chronique
- **D** Cancer de la prostate localisé
- **E** Cancer du rein et lymphomes

**Q59** **EX** **DX.9 · adulte sain** Prise en charge · cabinet

Une femme de 35 ans, sans antécédent, a depuis 6 heures une fièvre brutale à 38,9 °C, des courbatures et une toux, en pleine épidémie de grippe. SpO2 98 %.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Attendre le résultat de la PCR avant toute décision
- **B** Co-amoxicilline préventive
- **C** Traitement symptomatique, sans PCR obligatoire
- **D** Hospitalisation pour antiviral i.v.
- **E** Radiographie du thorax systématique

**Q60** **AP** **DX.9 · grippe sans fièvre** Évaluation / diagnostic · EMS

Pendant une épidémie de grippe dans un EMS, une résidente de 88 ans devient confuse, tousse et mange moins. Température 37,4 °C.

**Quelle affirmation est correcte ?**

- **A** Sans fièvre, la grippe est exclue
- **B** Une PCR est inutile chez elle
- **C** La confusion exclut une infection respiratoire
- **D** L'absence de fièvre n'exclut pas la grippe
- **E** Seule une sérologie tardive peut conclure

**Q61** **AP** **DX.9 · clairance 45 mL/min** Prise en charge · cabinet

Un homme de 79 ans, insuffisant cardiaque, a une grippe confirmée depuis 20 heures. Clairance de la créatinine 45 mL/min.

**Quelle posologie d'oseltamivir est correcte ?**

- **A** 75 mg 2×/j pendant 5 jours
- **B** 30 mg 1×/j pendant 5 jours
- **C** 75 mg 1×/j pendant 10 jours
- **D** 30 mg 2×/j pendant 5 jours
- **E** 150 mg 2×/j pendant 5 jours

**Q62** **SPE · Infectiologie** **DX.9 · baloxavir** Prise en charge · cabinet

Un homme de 45 ans, 70 kg, a des symptômes de grippe depuis 30 heures. Il souhaite un traitement en prise unique.

**Quelle posologie de baloxavir est correcte selon l'AIPS ?**

- **A** 80 mg en dose unique
- **B** 40 mg en dose unique dans les 48 h
- **C** 40 mg 2×/j pendant 5 jours
- **D** 75 mg 2×/j pendant 5 jours
- **E** 20 mg une fois par jour pendant 3 jours

**Q63** **EX** **DX.10 · vomissements bilieux** Évaluation / diagnostic · urgences

Un nourrisson de 7 mois vomit depuis 8 heures. Les vomissements sont devenus verts. Il pleure par crises. Selles peu abondantes.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Solution de réhydratation orale et contrôle à 24 h
- **B** Ondansétron et retour à domicile
- **C** Coproculture
- **D** Imagerie et avis chirurgical en urgence
- **E** Diète et reprise progressive

**Q64** **AP** **DX.10 · ondansétron** Prise en charge · urgences

Une fille de 5 ans a une gastro-entérite avec des vomissements qui empêchent la réhydratation orale. Le médecin envisage l'ondansétron.

**Quelle affirmation sur l'ondansétron est correcte ?**

- **A** Il est l'antidiarrhéique de choix
- **B** Il remplace la réhydratation orale
- **C** Il est interdit avant 6 ans par l'AIPS
- **D** Il est indiqué en routine dès le premier vomissement
- **E** Pas d'indication AIPS dans la gastro-entérite

**Q65** **SPE · Néphrologie** **DX.10 · EHEC suspecté** Prise en charge · hôpital

Un garçon de 6 ans a une diarrhée sanglante depuis 4 jours. Il est pâle, urine peu. Hémoglobine basse, plaquettes 60 G/L, créatinine en hausse.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Lopéramide et réhydratation orale à domicile avec contrôle
- **B** Hospitaliser, sans antidiarrhéique ni antibiotique
- **C** Ciprofloxacine d'emblée
- **D** Ibuprofène contre la douleur
- **E** Coloscopie en urgence

**Q66** **AP** **DX.11 · définition Sepsis-3** Mécanismes · hôpital

Une femme de 63 ans a une pneumonie. Son SOFA de base est 0. Aujourd'hui, plaquettes 85 G/L et Glasgow 13.

**Quel élément définit le sepsis selon Sepsis-3 ?**

- **A** Deux critères SIRS ou plus présents au triage
- **B** qSOFA ≥ 2
- **C** Infection et hausse du SOFA ≥ 2 points
- **D** Hémoculture positive
- **E** CRP > 100 mg/L

**Q67** **AP** **DX.11 · bactériémie ou sepsis** Mécanismes · hôpital

Un homme de 55 ans a une hémoculture positive à E. coli. Il est apyrétique sous antibiotique, ses constantes et ses fonctions d'organes sont normales.

**Comment qualifier cette situation ?**

- **A** Sepsis
- **B** Choc septique
- **C** Endocardite certaine
- **D** Bactériémie sans sepsis
- **E** Contamination certaine du prélèvement

**Q68** **SPE · Médecine intensive** **DX.11 · vasopresseur persistant** Prise en charge · hôpital

Une femme de 70 ans en choc septique abdominal reçoit de la noradrénaline à dose croissante, avec vasopressine ajoutée. La PAM reste à 62 mmHg.

**Quelle mesure peut être envisagée selon la SSC 2021 ?**

- **A** Dexaméthasone 10 mg toutes les 6 heures
- **B** Procalcitonine pour décider de l'antibiotique
- **C** Hydrocortisone
- **D** Arrêt de l'antibiotique
- **E** Albumine 20 % seule

**Q69** **AP** **DX.11 · procalcitonine** Prise en charge · urgences

Un homme de 62 ans est fébrile à 38,9 °C, FC 112/min, PA 92/55 mmHg, lactate 3,1 mmol/L. L'interne propose d'attendre la procalcitonine avant l'antibiotique.

**Quelle réponse est la plus appropriée ?**

- **A** Attendre la procalcitonine
- **B** Attendre la CRP de contrôle à 24 h
- **C** Attendre les hémocultures positives
- **D** Attendre l'apparition d'un foyer clinique évident
- **E** Antibiotique sans attendre la procalcitonine

**Q70** **EX** **DX.12 · après 50 ans** Prise en charge · urgences

Une femme de 72 ans a une méningite bactérienne probable : fièvre, raideur de nuque, LCR trouble. La dexaméthasone et la ceftriaxone ont été débutées.

**Quel antibiotique faut-il ajouter ?**

- **A** Aciclovir systématique
- **B** Gentamicine
- **C** Clarithromycine
- **D** Aucun : la ceftriaxone suffit à elle seule
- **E** Ampicilline ou amoxicilline i.v.

**Q71** **EX** **DX.12 · contact étroit** Prise en charge · cabinet

Un étudiant de 20 ans a une infection invasive à méningocoque confirmée. Plusieurs personnes demandent une prophylaxie.

**Quelle personne est un contact étroit ?**

- **A** Un passager assis dans le même train
- **B** Un collègue du même étage
- **C** Un voisin de l'immeuble
- **D** Son colocataire du même appartement
- **E** Un passager du même avion à 10 rangs

**Q72** **AP** **DX.12 · LCR peu cellulaire** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 66 ans a une fièvre à 39,5 °C et une confusion. Ponction lombaire : 640 cellules/µL à prédominance neutrophile, protéines 2,1 g/L, quotient glucose 0,2, lactate 6 mmol/L.

**Quelle interprétation est correcte ?**

- **A** Méningite virale : < 1000 cellules
- **B** LCR normal
- **C** Méningite tuberculeuse certaine
- **D** Hémorragie méningée
- **E** Méningite bactérienne probable

**Q73** **SPE · Infectiologie** **DX.12 · contact enceinte** Prise en charge · cabinet

Une femme de 31 ans, enceinte de 20 semaines, vit avec un patient hospitalisé pour méningococcie.

**Quelle prophylaxie est la plus appropriée ?**

- **A** Ciprofloxacine 500 mg per os
- **B** Rifampicine 600 mg 2×/j pendant 2 jours
- **C** Aucune prophylaxie
- **D** Vaccin seul sans antibiotique
- **E** Ceftriaxone 250 mg i.m. en dose unique

**Q74** **EX** **DX.13 · indication opératoire urgente** Prise en charge · hôpital

Un homme de 58 ans a une endocardite aortique à S. aureus. Brutalement, il devient dyspnéique avec un œdème pulmonaire, en rapport avec une régurgitation aortique sévère.

**Quel délai opératoire est le plus approprié ?**

- **A** Chirurgie dans les 24 heures
- **B** Chirurgie après 6 semaines d'antibiotique
- **C** Chirurgie dans les 3 mois
- **D** Aucune chirurgie : l'antibiotique suffit
- **E** Chirurgie à la négativation des hémocultures

**Q75** **AP** **DX.13 · critères de Duke** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 64 ans a une fièvre à 38,6 °C, une prothèse mitrale et des streptocoques typiques dans deux hémocultures. L'ETO montre une végétation.

**Comment classer l'endocardite selon Duke-ISCVID 2023 ?**

- **A** Possible : un majeur et un mineur
- **B** Rejetée faute de souffle
- **C** Possible : trois mineurs
- **D** Inclassable sans chirurgie
- **E** Certaine : deux critères majeurs

**Q76** **SPE · Infectiologie** **DX.13 · SARM du cœur droit** Prise en charge · hôpital

Un homme de 30 ans qui s'injecte des drogues a une endocardite tricuspide à S. aureus résistant à la méticilline.

**Quel antibiotique est indiqué selon l'AIPS ?**

- **A** Flucloxacilline 12 g/j
- **B** Ceftriaxone 2 g/j
- **C** Amoxicilline-acide clavulanique
- **D** Clarithromycine i.v.
- **E** Daptomycine 6 mg/kg/24 h i.v.

**Q77** **SPE · Cardiologie** **DX.13 · aminoside sur valve native** Prise en charge · hôpital

Une femme de 47 ans a une endocardite sur valve mitrale native à S. aureus sensible à la méticilline. Elle reçoit de la flucloxacilline.

**Faut-il ajouter de la gentamicine ?**

- **A** Oui, pendant 6 semaines
- **B** Oui, à la place de la flucloxacilline
- **C** Non, pas d'aminoside sur valve native
- **D** Oui, seulement si la créatinine est normale
- **E** Oui, en dose unique avant la chirurgie

**Q78** **EX** **DX.14 · faible risque** Prise en charge · policlinique

Une femme de 44 ans sous chimiothérapie pour un cancer du sein a une neutropénie fébrile. Score MASCC 23. Elle est fiable, entourée, et vit à 10 minutes de l'hôpital.

**Quelle conduite est possible ?**

- **A** Hospitalisation obligatoire en soins intensifs
- **B** Aucun antibiotique
- **C** Antibiotique oral en ambulatoire
- **D** Antifongique empirique d'emblée
- **E** Filgrastim seul

**Q79** **SPE · Hématologie** **DX.14 vs DX.4 · fièvre persistante** Prise en charge · hôpital

Un homme de 49 ans en aplasie après chimiothérapie pour une leucémie aiguë reste fébrile après 6 jours de méropénème. Cultures négatives.

**Que faut-il rechercher ?**

- **A** Une fièvre factice
- **B** Un coup de chaleur
- **C** Une FUO classique
- **D** Une maladie de Still
- **E** Une infection fongique

**Q80** **SPE · Hématologie** **DX.14 · cathéter infecté** Prise en charge · hôpital

Une femme de 57 ans neutropénique fébrile sous céfépime a une rougeur et du pus au point d'entrée de son cathéter veineux central.

**Quel antibiotique faut-il ajouter ?**

- **A** Clarithromycine
- **B** Métronidazole
- **C** Vancomycine
- **D** Oseltamivir
- **E** Aucun : le céfépime suffit

**Q81** **AP** **DX.14 · CRP normale** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 66 ans sous chimiothérapie a 38,4 °C depuis 1 heure. Neutrophiles 0,3 G/L. CRP 6 mg/L. Il se sent bien et n'a aucun foyer.

**Quelle interprétation est correcte ?**

- **A** La CRP normale ne rassure pas
- **B** La CRP normale exclut une infection bactérienne
- **C** L'absence de foyer exclut une infection
- **D** La fièvre est due à la chimiothérapie, sans infection
- **E** Une surveillance sans antibiotique suffit

**Q82** **EX** **DX.15 vs DX.11 · épuisement par la chaleur** Évaluation / diagnostic · terrain

Un ouvrier de 45 ans travaille sur un toit par 33 °C. Il a des crampes, des nausées et une grande fatigue. Il est parfaitement orienté. Température rectale 38,9 °C.

**Quel est le diagnostic le plus probable ?**

- **A** Coup de chaleur d'effort
- **B** Méningite bactérienne
- **C** Sepsis
- **D** Paludisme
- **E** Épuisement par la chaleur

**Q83** **EX** **DX.15 · site de mesure** Évaluation / diagnostic · terrain

Une femme de 22 ans s'effondre confuse à la fin d'une course par forte chaleur. La température tympanique indique 38,7 °C.

**Quelle mesure faut-il prendre pour décider ?**

- **A** Se fier à la mesure tympanique
- **B** Mesurer la température rectale
- **C** Mesurer la température buccale
- **D** Palper la peau
- **E** Attendre la CK

**Q84** **AP** **DX.15 vs DX.1 · hyperthermie ou fièvre** Mécanismes · hôpital

Un étudiant compare la fièvre d'une pneumonie et l'hyperthermie d'un coup de chaleur.

**Quel mécanisme distingue l'hyperthermie de la fièvre ?**

- **A** Consigne relevée par la prostaglandine E2
- **B** Libération d'interleukine 1 et de TNF-α
- **C** Consigne hypothalamique normale
- **D** Induction de la COX-2 cérébrale
- **E** Action sur les récepteurs EP3 préoptiques

**Q85** **SPE · Médecine intensive** **DX.15 · soluté et foie** Prise en charge · hôpital

Un homme de 34 ans est en soins intensifs pour un coup de chaleur d'effort. ASAT et ALAT sont très élevées, l'INR augmente. Il reste hypovolémique.

**Quel soluté de remplissage est le plus approprié ?**

- **A** Ringer-lactate
- **B** Glucose 5 %
- **C** Albumine 20 % en première intention
- **D** Aucun soluté
- **E** NaCl 0,9 %

## 🚩 Pièges & alarmes · 15 Q · ce qu'il ne faut jamais rater

qSOFA rassurant à tort, bactériurie asymptomatique, hémocultures de la cellulite, lopéramide avant 6 ans, toucher rectal du neutropénique, métamizole, dose de paracétamol, AINS au 3e trimestre, souffle absent, doses rénales.

**Q86** **EX** **DX.11 · qSOFA rassurant** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 69 ans a une fièvre à 38,8 °C et des frissons solennels depuis ce matin. FR 20/min, conscience normale, PA 108/66 mmHg : qSOFA 0. Il est pâle et marbré aux genoux.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

- **A** Retour à domicile, car le qSOFA à 0 exclut le sepsis
- **B** Paracétamol et réévaluation le lendemain
- **C** Calculer le SIRS et conclure
- **D** Mesurer le lactate et prélever des hémocultures
- **E** Attendre que la PA baisse avant d'agir

**Q87** **EX** **DX.2 · bactériurie sans symptôme** Prise en charge · EMS

Une résidente d'EMS de 85 ans, apyrétique et sans plainte, a une bandelette urinaire positive et une uroculture à E. coli faites lors d'un contrôle systématique. Constantes normales.

**Quelle est la conduite la plus appropriée ?**

- **A** Ciprofloxacine 7 jours
- **B** Ceftriaxone i.v. en hospitalisation
- **C** Échographie rénale en urgence
- **D** Pas d'antibiotique
- **E** Nouvelle uroculture et traitement si positive

**Q88** **EX** **DX.3 · hémocultures systématiques ?** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 50 ans a un érysipèle de jambe non compliqué, sans sepsis ni immunodépression. L'assistante demande s'il faut des hémocultures.

**Quelle réponse est la plus appropriée ?**

- **A** Oui : elles posent le diagnostic
- **B** Non : réservées au sepsis ou à l'immunodépression
- **C** Oui : trois paires avant tout antibiotique
- **D** Oui : une culture négative exclut la cellulite
- **E** Non : un prélèvement cutané suffit à confirmer

**Q89** **EX** **DX.10 · enfant de 4 ans** Prise en charge · cabinet **question négative**

Une fillette de 4 ans a une gastro-entérite aqueuse sans sang, sans fièvre élevée. Elle boit bien. La mère demande un médicament.

**Quel médicament est contre-indiqué ?**

- **A** Solution de réhydratation orale
- **B** Paracétamol à dose adaptée au poids
- **C** Petites quantités de boisson fréquentes
- **D** Lopéramide
- **E** Alimentation habituelle

Q90 EX **DX.14 · examen du neutropénique** Évaluation / diagnostic · urgences **question négative**

Une femme de 61 ans neutropénique fébrile (neutrophiles 0,1 G/L) se plaint d'une gêne anale. Les hémocultures sont prélevées et l'antibiotique est en cours.

**Quel geste est contre-indiqué ?**

A Inspection de la région périanale

B Examen de la cavité buccale

C Inspection du point du cathéter

D Auscultation pulmonaire

E Toucher rectal

Q91 EX **DX.14 · fièvre sous métamizole** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 63 ans prend du métamizole depuis 3 semaines pour des douleurs. Elle consulte pour une fièvre à 38,8 °C et une angine.

**Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?**

A Augmenter le métamizole pour la fièvre

B Pénicilline V pour l'angine et contrôle à 1 semaine

C Arrêter le métamizole et faire une formule sanguine

D Test rapide streptococcique seul

E Ibuprofène et gargarismes

**Q92** **EX** **DX.9 · dose de paracétamol** Prise en charge · domicile

Un homme de 40 ans, 78 kg, grippé, prend Dafalgan® 1 g quatre fois par jour. Il ajoute un sachet « grippe » contenant du paracétamol.

**Quel conseil est le plus approprié ?**

- **A** Passer à 6 g/j pendant la fièvre
- **B** Raccourcir l'intervalle à 2 heures
- **C** Ne pas dépasser 4 g/j, toutes sources comprises
- **D** Associer de l'acide acétylsalicylique pour la fièvre
- **E** Doubler la dose du soir

**Q93** **AP** **DX.9 · troisième trimestre** Prise en charge · cabinet **question négative**

Une femme de 32 ans enceinte de 34 semaines a une grippe avec fièvre à 38,8 °C et myalgies.

**Quel médicament est contre-indiqué ?**

- **A** Paracétamol
- **B** Oseltamivir
- **C** Ceftriaxone i.v.
- **D** Flucloxacilline
- **E** Ibuprofène

**Q94** **EX** **DX.13 · pas de souffle** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 67 ans porteur d'une prothèse aortique a une fièvre à 38,5 °C depuis 2 semaines. Aucun souffle n'est entendu. Les hémocultures ne sont pas encore faites.

**Quelle affirmation est correcte ?**

- **A** L'absence de souffle n'exclut pas l'endocardite
- **B** Sans souffle, l'endocardite est exclue
- **C** Une antibiothérapie empirique précède les hémocultures
- **D** Une seule hémoculture suffit
- **E** Une ETT normale clôt le bilan

**Q95** **AP** **DX.2 · co-trimoxazole et rein** Prise en charge · hôpital

Un homme de 76 ans a une pyélonéphrite à E. coli sensible au co-trimoxazole. Clairance de la créatinine 10 mL/min.

**Quelle affirmation est correcte ?**

- **A** Bactrim® forte ne doit pas être utilisé
- **B** Bactrim® forte à pleine dose
- **C** Bactrim® forte à demi-dose
- **D** Bactrim® forte avec un supplément de potassium
- **E** Bactrim® forte en dose unique

**Q96** **EX** **DX.1 · clairance 25 mL/min** Prise en charge · cabinet

Une femme de 81 ans a une pneumonie ambulatoire. Clairance de la créatinine 25 mL/min.

**Quelle posologie de co-amoxicilline est correcte ?**

- **A** 1000 mg 2×/j
- **B** 1000 mg 3×/j
- **C** 625 mg 3×/j
- **D** 625 mg toutes les 12 heures
- **E** 625 mg toutes les 24 heures

**Q97** **EX** **DX.4 · médicament fébrigène** Prise en charge · cabinet

Un homme de 58 ans a une fièvre à 38,4 °C sans foyer depuis 2 semaines. Il a commencé un nouvel anticonvulsivant il y a 5 semaines. Il est stable et l'examen est normal.

**Quelle mesure est la plus appropriée ?**

- **A** Arrêter ou remplacer le médicament suspect
- **B** Ajouter un antibiotique d'épreuve
- **C** Prednisone d'épreuve
- **D** FDG-TEP-TDM d'emblée
- **E** Ignorer le médicament, présent depuis plus de 4 semaines

**Q98** **SPE · Rhumatologie** **DX.5 · méthotrexate** Prise en charge · policlinique

Une femme de 55 ans traitée pour une maladie inflammatoire reçoit du méthotrexate. La pharmacienne vérifie l'ordonnance.

**Quel rythme d'administration est correct ?**

- **A** Une fois par jour
- **B** Une fois par semaine
- **C** Deux fois par jour
- **D** Un jour sur deux
- **E** Une fois par mois

**Q99** **AP** **DX.15 · dantrolène** Prise en charge · hôpital

Un homme de 24 ans en coup de chaleur d'effort est en cours d'immersion en eau froide. Un collègue propose du dantrolène.

**Quelle affirmation est correcte ?**

- **A** Le refroidissement rapide reste le seul traitement
- **B** Le dantrolène accélère le refroidissement
- **C** Le paracétamol i.v. complète utilement le refroidissement
- **D** Le dantrolène remplace l'immersion
- **E** L'ibuprofène protège le rein

Q100 AP **DX.12 · sortie après pénicilline** Prise en charge · hôpital

Un homme de 25 ans a été traité par pénicilline G pour une méningococcie. Il va bien et sort demain.

**Que faut-il prévoir avant la sortie ?**

A Rien : la pénicilline éradique le germe

B Une prophylaxie d'éradication du portage

C Une ponction lombaire de contrôle

D Un TEP au FDG

E Une corticothérapie orale

## ⇢ Algorithme condensé · si… alors…

| Si… | Alors… |
|---|---|
| **> 40 °C et confusion après chaleur ou effort** | DX.15 : refroidissement externe immédiat (immersion), 144 ; pas d'antipyrétique |
| **Hypotension, confusion ou polypnée** | DX.11 : lactate, hémocultures, antibiotique en < 1 h, cristalloïde ≥ 30 mL/kg, noradrénaline si PAM < 65 |
| **Céphalée, raideur, purpura** | DX.12 : hémocultures, dexaméthasone puis ceftriaxone ; ponction sans retarder ; scanner d'abord si coma, déficit, crise |
| **Neutrophiles < 0,5 G/L** | DX.14 : bêtalactamine antipseudomonale i.v. dans l'heure ; MASCC |
| **Séjour en zone palustre** | DX.6 : test rapide et frottis le jour même ; répéter à 12–24 h ; artésunate si grave |
| **Prothèse, souffle nouveau, drogues injectées** | DX.13 : 3 paires d'hémocultures, échocardiographie, ETO si ETT négative |
| Toux, dyspnée, infiltrat | DX.1 : score de gravité ; co-amoxicilline à domicile ou ceftriaxone + clarithromycine à l'hôpital |
| Douleur lombaire, culture positive | DX.2 : culture puis antibiotique ; imagerie si choc, obstruction ou échec à 72 h |
| Placard rouge, chaud, bien limité | DX.3 : bêtalactamine ; marquer la limite ; douleur disproportionnée → chirurgien |

| | |
|---|---|
| Diarrhée aiguë, vomissements | DX.10 : réhydratation orale ; coproculture si sang ou fièvre élevée |
| Fièvre brutale, toux, myalgies en saison | DX.9 : oseltamivir si terrain à risque, dans les 36 h |
| Retour de voyage, éruption, douleur rétro-orbitaire | DX.7 : PCR ou NS1 ; paracétamol, pas d'AINS ; signes d'alarme → hôpital |
| Fièvre ≥ 3 semaines, bilan de base négatif | DX.4 : FDG-TEP-TDM si VS/CRP élevées ; pas d'antibiotique ni de corticoïde si stable |
| > 50 ans, céphalée, trouble visuel, CRP élevée | DX.5 : corticoïde le jour même, échographie ou biopsie ensuite |
| Perte de poids, sueurs nocturnes, adénopathie | DX.8 : biopsie de la lésion accessible, sans corticoïde préalable |

Source : Phase A · Algorithme discriminant et §10 Arbre décisionnel.

## ✅ Corrigé commenté · à consulter après avoir répondu

**Q1** **EX** **DX.11 · fébrile et hypotendu**

✅ **A** — Hémocultures, puis antibiotique i.v. dans l'heure

① **Pourquoi c'est juste** Hypotension, confusion et polypnée : qSOFA à 3, sepsis probable (DX.11, 🚩 E2). On prélève deux séries d'hémocultures et le lactate sans retarder l'antibiotique i.v. à large spectre, donné dans l'heure, puis on remplit.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** On traite dès le soupçon ; le lactate ne doit pas retarder l'antibiotique.
- **C** L'imagerie du foyer vient après l'antibiotique, dans les 6 à 12 heures.
- **D** L'antipyrétique ne ferme aucune branche dangereuse.
- **E** Un patient en choc probable reçoit un traitement i.v. et une surveillance continue.

③ **Perle** Chaque heure de retard de l'antibiotique augmente la mortalité.

④ **Source** Phase A §11 Prise en charge · LOT_006 audité

**Q2** **EX** **DX.11 · remplissage**

✅ **B** — Cristalloïde balancé ≥ 30 mL/kg en 3 h

① **Pourquoi c'est juste** Lactate > 2 mmol/L et hypotension : hypoperfusion. La SSC 2021 recommande au moins 30 mL/kg de cristalloïde, de préférence balancé, dans les 3 premières heures, soit 1 800 mL pour 60 kg (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le glucose apporte de l'eau libre et n'a pas d'effet volémique durable.
- **C** Le remplissage précède le vasopresseur.
- **D** Les cristalloïdes balancés restent la première ligne.
- **E** Volume très insuffisant pour corriger l'hypoperfusion.

③ **Perle** Le remplissage est guidé par des mesures dynamiques et le temps de recoloration capillaire.

④ **Source** Phase B DX.11 §11 · LOT_006 audité

**Q3** **EX** **DX.11 · PAM basse**

✅ **D** — Noradrénaline pour une PAM ≥ 65 mmHg

① **Pourquoi c'est juste** Hypotension persistante après remplissage avec lactate > 2 mmol/L : choc septique (DX.11). La noradrénaline vise une PAM de 65 mmHg ; elle peut passer par une voie périphérique en attendant la voie centrale.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Au-delà du remplissage initial, on évite la surcharge ; le vasopresseur s'impose.
- **B** Elle n'est envisagée qu'en cas de besoin persistant de vasopresseur.
- **C** Le vasopresseur de première ligne est la noradrénaline.
- **E** Les cultures ne modifient pas la prise en charge hémodynamique immédiate.

③ **Perle** Choc septique : mortalité hospitalière > 40 %.

④ **Source** Phase B DX.11 §10 · LOT_006 audité

**Q4** **EX** **DX.12 vs DX.11 · purpura fébrile**

✅ **E** — Ceftriaxone i.v. immédiate, puis transfert

① **Pourquoi c'est juste** Un purpura fébrile est une méningococcémie jusqu'à preuve du contraire (DX.12, 🚩 E3). La ceftriaxone se donne immédiatement, avant toute imagerie ou ponction, puis le patient est isolé par gouttelettes.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le purpura fébrile impose l'antibiotique avant tout examen.
- **B** L'imagerie ne doit pas retarder l'antibiotique.
- **C** La méningococcie évolue en heures vers le choc.
- **D** Aucun examen ne justifie d'attendre devant un purpura fébrile.

③ **Perle** Létalité de l'infection invasive à méningocoques en Suisse : 7,3 %.

④ **Source** Phase B DX.12 §13 · LOT_006 audité

**Q5** **EX** **DX.12 · conscient, sans déficit**

✅ **B** — Ponction lombaire, puis dexaméthasone et antibiotique

① **Pourquoi c'est juste** Conscience conservée, sans déficit focal ni crise nouvelle : la ponction lombaire se fait sans délai, puis dexaméthasone et antibiotique (DX.12). L'antibiotique démarre si possible dans l'heure suivant l'arrivée.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans trouble de conscience, déficit ni crise, l'imagerie n'est pas requise.
- **C** La méningite bactérienne reste à couvrir en premier.
- **D** La méningite bactérienne évolue en heures.
- **E** Le délai est incompatible avec l'urgence.

③ **Perle** Le scanner d'abord seulement si conscience altérée, déficit focal, crise nouvelle, œdème papillaire ou immunodépression.

④ **Source** Phase B DX.12 §10 · LOT_006 audité

**Q6** **EX** **DX.12 · conscience altérée**

✅ **D** — Dexaméthasone et antibiotique, puis scanner

① **Pourquoi c'est juste** Trouble de conscience sévère ou crise nouvelle : hémocultures, dexaméthasone et antibiotique d'abord, puis tomodensitométrie, puis ponction si l'imagerie ne la contre-indique pas (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'imagerie ne doit pas retarder l'antibiotique.
- **B** Coma et crise imposent l'imagerie avant la ponction.
- **C** L'EEG ne précède pas le traitement de la méningite.
- **E** La dexaméthasone accompagne l'antibiotique ; elle ne le remplace pas.

③ **Perle** La dexaméthasone se donne juste avant ou avec la première dose d'antibiotique (essai de Gans : RR de décès 0,48).

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_006 audité

**Q7** **EX** **DX.15 · coureur confus**

✅ **C** — Immersion du corps en eau froide

① **Pourquoi c'est juste** Température centrale > 40 °C avec dysfonction neurologique après effort : coup de chaleur d'effort (DX.15, 🚩 E1). L'immersion en eau froide du corps entier refroidit le plus vite ; on appelle le 144.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La consigne hypothalamique est normale : l'antipyrétique n'agit pas.
- **B** On refroidit avant les examens.
- **D** Réponse de l'épuisement par la chaleur, pas d'un coup de chaleur.
- **E** La confusion s'explique par l'hyperthermie ; refroidir d'abord.

③ **Perle** La peau peut rester moite dans la forme d'effort ; la sueur n'exclut pas le diagnostic.

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_006 audité

**Q8** **EX** **DX.15 · personne âgée en canicule**

✅ **D** — Refroidissement actif immédiat et appel du 144

① **Pourquoi c'est juste** Coup de chaleur classique (exposition passive) : sortir de la chaleur, retirer les vêtements, appeler le 144, refroidir sans délai (DX.15). Mortalité en soins intensifs : 63,2 % dans la forme classique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les antipyrétiques n'agissent pas dans l'hyperthermie.
- **B** Le refroidissement passe avant les examens.
- **C** Elle aggrave l'hyperthermie.
- **E** Chaque minute de température élevée aggrave le pronostic.

③ **Perle** La durée de la température élevée détermine les lésions.

④ **Source** Phase B DX.15 §8 · LOT_006 audité

**Q9** **EX** **DX.14 · fièvre sous chimiothérapie**

✅ **C** — Formule sanguine et hémocultures en urgence

① **Pourquoi c'est juste** Toute fièvre sous chimiothérapie impose une formule sanguine en urgence (DX.14, 🚩 E4). Si les neutrophiles sont < 0,5 G/L : deux séries d'hémocultures puis antibiotique i.v. dans l'heure suivant le triage.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Toute fièvre sous chimiothérapie est une urgence.
- **B** La numération oriente d'abord la conduite.
- **D** Sans neutrophiles, les signes locaux manquent.
- **E** Une CRP normale ne rassure pas chez le neutropénique.

③ **Perle** La fièvre est parfois le seul signe d'infection chez le neutropénique.

④ **Source** Phase B DX.14 §13 · LOT_006 audité

**Q10** **EX** **DX.14 · neutrophiles effondrés**

✅ **D** — Pipéracilline-tazobactam i.v. dans l'heure

① **Pourquoi c'est juste** Neutropénie fébrile à haut risque : une bêtalactamine antipseudomonale en monothérapie i.v. dans l'heure (pipéracilline-tazobactam, céfépime ou méropénème) (DX.14).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le spectre et la voie sont inadaptés au neutropénique à haut risque.
- **B** Elle ne couvre pas Pseudomonas.
- **C** Il raccourcit la neutropénie ; il ne remplace pas l'antibiotique.
- **E** L'antibiotique ne doit pas attendre les cultures.

③ **Perle** Céfépime : 2 g toutes les 8 h ; méropénème : 1 g toutes les 8 h (AIPS).

④ **Source** Phase B DX.14 §11 · LOT_006 audité

**Q11** **EX** **DX.6 · retour d'Afrique**

✅ **D** — Test rapide et frottis-goutte épaisse le jour même

① **Pourquoi c'est juste** Toute fièvre au retour d'une zone d'endémie se teste le jour même par test rapide, frottis et goutte épaisse, même sous prophylaxie (DX.6, 🚩 E5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le paludisme, mortel, passe en premier.
- **B** La prophylaxie ne protège pas totalement.
- **C** Sans signe respiratoire, elle n'exclut pas le paludisme.
- **E** Le délai est dangereux pour un P. falciparum.

③ **Perle** Le paludisme représente 21,1 % des fièvres aiguës sans foyer chez 455 voyageurs européens.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_006 audité

**Q12** **EX** **DX.6 vs DX.7 · frottis négatif**

✅ **E** — Répéter les tests du paludisme à 12–24 h

① **Pourquoi c'est juste** Une parasitémie basse échappe au premier examen : on répète frottis et test rapide à 12–24 h si la suspicion persiste, et l'on cherche la dengue ou une bactérie (DX.6, DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un premier test négatif n'exclut pas : la parasitémie peut être basse.
- **B** Le traitement se décide sur un diagnostic parasitologique.
- **C** Aucune place dans une fièvre aiguë du voyageur.
- **D** Elle ne sert pas au diagnostic de l'accès aigu.

③ **Perle** La thrombopénie oriente mais ne prouve pas le paludisme.

④ **Source** Phase B DX.6 §10 · LOT_006 audité

**Q13** **EX** **DX.6 · paludisme grave**

✅ **C** — Artésunate i.v. en soins intensifs

① **Pourquoi c'est juste** Confusion, hypoglycémie, atteinte rénale et parasitémie ≥ 10 % : paludisme grave (DX.6). Artésunate i.v. en soins intensifs, au moins 24 h, puis cure orale complète de 3 jours ; on corrige l'hypoglycémie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Riamet® est contre-indiqué dans le paludisme grave (AIPS).
- **B** La voie orale ne convient pas à un paludisme grave.
- **D** Elle n'est pas indiquée dans le paludisme grave à P. falciparum.
- **E** Elle n'est pas un schizonticide rapide.

③ **Perle** La quinine reste l'alternative si l'artésunate manque ; surveiller l'hémolyse après le traitement.

④ **Source** Phase B DX.6 §11 · LOT_006 audité

**Q14** **EX** **DX.13 vs DX.11 · fièvre et drogues injectées**

✅ **B** — Trois paires d'hémocultures avant l'antibiotique

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre avec drogues injectées et souffle nouveau : endocardite à évoquer (DX.13, 🚩 E6). On prélève trois paires d'hémocultures avant tout antibiotique, puis échocardiographie et avis de l'équipe d'endocardite.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un antibiotique préalable rend les hémocultures négatives.
- **C** Microbiologie et imagerie sont deux critères majeurs.
- **D** Une hémoculture isolée ne suffit pas.
- **E** Le retard de traitement augmente la mortalité.

③ **Perle** Patient stable : le prélèvement correct passe avant l'antibiotique.

④ **Source** Phase B DX.13 §13 · LOT_006 audité

**Q15** **EX** **DX.13 · ETT négative**

✅ **A** — Échocardiographie transœsophagienne

① **Pourquoi c'est juste** Suspicion forte avec ETT négative : passer à la voie transœsophagienne, puis scanner ou TEP au FDG si besoin (Duke-ISCVID 2023) (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Une ETT négative n'exclut pas l'endocardite.
- **C** Elle ne montre pas les lésions valvulaires.
- **D** Le délai est incompatible avec la gravité.
- **E** Elle n'a pas sa place sans signe méningé.

③ **Perle** Germe typique dans au moins deux hémocultures = critère majeur.

④ **Source** Phase B DX.13 §10 · LOT_006 audité

**Q16** **EX** **DX.1 · score à 0**

✅ **B** — Co-amoxicilline 2 × 1 g/j per os, contrôle à 48–72 h

① **Pourquoi c'est juste** Pneumonie communautaire avec score de gravité à 0 et contexte sûr : traitement ambulatoire par amoxicilline-acide clavulanique 2 × 1000 mg ou 3 × 625 mg par jour, réévaluation à 48–72 h (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Score à 0 et contexte sûr : le domicile suffit.
- **C** Il ne traite pas une pneumonie bactérienne.
- **D** Une pneumonie radiologique se traite.
- **E** Elle ne cible pas en premier le pneumocoque.

③ **Perle** Mortalité à 30 jours : 0,7 % avec un CURB-65 à 0.

④ **Source** Phase B DX.1 §10 · LOT_006 audité

Q17 EX DX.1 vs DX.11 · pneumonie sévère

✅ **D** — Ceftriaxone et clarithromycine i.v., soins intensifs

① **Pourquoi c'est juste** Confusion, FR ≥ 30/min, PA basse, urée et âge : score de gravité maximal (DX.1, DX.11). Hospitalisation, ceftriaxone i.v. 1 à 2 g/j associée à la clarithromycine i.v. 500 mg 2 fois par jour, 5 jours au maximum ; évaluer les soins intensifs.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Score très élevé : hospitalisation et voie i.v.
- **B** Inadaptée à une pneumonie sévère.
- **C** Le pneumocoque doit être couvert par une bêtalactamine i.v.
- **E** L'antibiotique ne doit pas attendre les résultats.

③ **Perle** CURB-65 à 4 : mortalité à 30 jours 41,5 %.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_006 audité

Q18 EX DX.2 · pyélonéphrite simple

✅ **C** — Uroculture, puis ciprofloxacine 2 × 500 mg/j 7 jours

① **Pourquoi c'est juste** Pyélonéphrite simple de la femme non enceinte : ECBU avant l'antibiotique, puis ciprofloxacine 500 mg deux fois par jour pendant 7 jours (AIPS) (DX.2). Réévaluation à 48–72 h.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Traitement de la cystite, pas de l'atteinte rénale.
- **B** Forme simple sans sepsis : la voie orale suffit.
- **D** La culture se prélève avant l'antibiotique.
- **E** L'imagerie est réservée au choc, à l'obstruction ou à l'échec à 72 h.

③ **Perle** Guérison clinique 97 % à 7 jours, non inférieure à 14 jours (essai suédois).

④ **Source** Phase B DX.2 §13 · LOT_006 audité

**Q19** **SPE · Urologie** **DX.2 vs DX.11 · obstruction et choc**

✅ **A** — Ceftriaxone i.v. et drainage urologique urgent

① **Pourquoi c'est juste** Pyélonéphrite obstructive avec sepsis : antibiotique i.v. (ceftriaxone), remplissage, puis avis urologique et drainage en urgence (DX.2, DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Choc et obstruction imposent l'hospitalisation et le drainage.
- **C** Une obstruction infectée ne se surveille pas.
- **D** L'antibiotique ne stérilise pas une cavité obstruée.
- **E** Le drainage est urgent, la lithotripsie différée.

③ **Perle** Une obstruction infectée exige un drainage en plus de l'antibiotique.

④ **Source** Phase B DX.2 §11 · LOT_006 audité

**Q20** **EX** **DX.3 · douleur disproportionnée**

✅ **B** — Avis chirurgical immédiat pour exploration

① **Pourquoi c'est juste** Douleur disproportionnée, bulles et choc : fasciite nécrosante jusqu'à preuve du contraire (DX.3). Antibiotique large i.v. avec clindamycine, et exploration-débridement chirurgical en urgence.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Fasciite suspectée : la chirurgie seule sauve le tissu.
- **C** Le délai fait progresser la nécrose en heures.
- **D** L'imagerie ne doit pas retarder la chirurgie.
- **E** Un LRINEC bas n'exclut pas la fasciite ; la clinique l'emporte.

③ **Perle** La confondre avec une cellulite simple retarde le débridement.

④ **Source** Phase B DX.3 §10 · LOT_006 audité

Q21 EX DX.4 · FUO stable

✅ **D** — Aucun antibiotique ; poursuivre le bilan

① **Pourquoi c'est juste** Trois semaines ou plus, 38,3 °C documentés deux fois, sans immunosuppression, bilan de base négatif : FUO (DX.4). Chez le patient stable, ni antibiotique ni corticoïde d'épreuve : ils masquent la cause.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'antibiotique d'épreuve masque la cause.
- **B** Le corticoïde masque un lymphome ou une infection.
- **C** Il faut poursuivre la recherche structurée.
- **E** Aucun signe d'instabilité ne la justifie.

③ **Perle** Arrêter ou remplacer tous les médicaments, même anciens, et conserver un sérum de départ.

④ **Source** Phase B DX.4 §13 · LOT_006 audité

Q22 EX DX.4 · FUO et VS élevée

✅ **A** — FDG-TEP-TDM

① **Pourquoi c'est juste** FUO avec VS ou CRP élevée : FDG-TEP-TDM tôt, puis biopsie de la cible (DX.4). Rendement de 40 à 60 % contre 25 à 35 % pour le scanner.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Rendement de 25 à 35 %, inférieur au TEP.
- **C** Elle n'est pas l'examen de choix de la FUO.
- **D** Sans signe neurologique, rendement faible.
- **E** Elle a déjà été faite sans diagnostic.

③ **Perle** Avec VS et CRP normales, le TEP n'a aidé aucun patient dans l'étude néerlandaise.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_006 audité

Q23 EX DX.5 · céphalée et vue

✅ **A** — Corticothérapie le jour même, sans attendre la biopsie

① **Pourquoi c'est juste** Après 50 ans, céphalée nouvelle et trouble visuel : artérite à cellules géantes (DX.5). Corticothérapie immédiate, hospitalisation et avis ophtalmologique le jour même ; échographie ou biopsie ensuite.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** La perte visuelle est irréversible : on traite d'abord.
- **C** Traitement inadapté de l'artérite.
- **D** L'imagerie ne doit pas retarder les corticoïdes.
- **E** Le tableau est inflammatoire, non infectieux.

③ **Perle** Classification ACR/EULAR 2022 : sensibilité 87,0 %, spécificité 94,8 %.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_006 audité

Q24 EX DX.7 · défervescence

✅ **B** — Hospitalisation pour surveillance stricte

① **Pourquoi c'est juste** Douleur abdominale intense et vomissements persistants : signes d'alarme, à la défervescence qui est la phase critique (DX.7). Hospitalisation, hydratation et contrôles répétés de l'hématocrite et des signes vitaux.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La défervescence est la phase critique de la dengue.
- **C** Les AINS augmentent le risque hémorragique.
- **D** Aucune indication préventive ; risque de surcharge.
- **E** Les corticoïdes n'ont pas de place dans la dengue.

③ **Perle** La fuite plasmatique peut apparaître au moment où la fièvre tombe.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_006 audité

**Q25** **EX** **DX.7 vs DX.6 · NS1 positif**

✅ **D** — Test rapide et frottis du paludisme le jour même

① **Pourquoi c'est juste** Devant une fièvre au retour des tropiques, le paludisme s'exclut le jour même par test rapide et frottis, même si une autre cause est trouvée (DX.7, DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le paludisme se cherche quand même : il est mortel et peut coexister.
- **B** Les IgG ne servent pas au diagnostic aigu.
- **C** Les AINS sont à éviter dans la dengue.
- **E** Aucune place des corticoïdes.

③ **Perle** La dengue représente 85,2 % des arboviroses chez 455 voyageurs fébriles européens.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_006 audité

**Q26** **EX** **DX.9 · grippe chez un patient à risque**

✅ **C** — Oseltamivir 75 mg 2×/j pendant 5 jours

① **Pourquoi c'est juste** Grippe sur terrain à risque, vue dans les 36 premières heures : oseltamivir 75 mg deux fois par jour pendant 5 jours (AIPS Tamiflu®) (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les antibiotiques ne traitent pas la grippe.
- **B** Dose réservée à une clairance de 10 à 30 mL/min.
- **D** Le terrain à risque justifie l'antiviral précoce.
- **E** Aucune indication dans la grippe non compliquée.

③ **Perle** Sous oseltamivir, les hospitalisations toutes causes passent de 1,7 % à 0,6 %.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_006 audité

**Q27** **EX** **DX.9 vs DX.1 · fièvre qui repart**

✅ **C** — Radiographie du thorax

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre qui repart après amélioration ou crépitants focaux : radiographie du thorax à la recherche d'une pneumonie (DX.9, DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle ne recherche pas la surinfection bactérienne.
- **B** Sans intérêt pour la décision.
- **D** Fièvre qui repart et signe focal évoquent une surinfection.
- **E** Pas d'indication sans souffle ni facteur de risque.

③ **Perle** Les antibiotiques traitent la surinfection, pas la grippe.

④ **Source** Phase B DX.9 §10 · LOT_006 audité

**Q28** **EX** **DX.10 · déshydratation modérée**

✅ **B** — Réhydratation orale 40–50 mL/kg en 4–6 h

① **Pourquoi c'est juste** Déshydratation modérée (perte de 5 à 8 % du poids) : solution de réhydratation orale 40 à 50 mL/kg dans les 4 à 6 premières heures, soit 560 à 700 mL pour 14 kg (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La voie orale est supérieure ; la perfusion est réservée à l'échec.
- **C** Interdit avant 6 ans.
- **D** L'alimentation habituelle se poursuit.
- **E** Il n'est pas indiqué en routine.

③ **Perle** L'enfant qui vomit reçoit de petites quantités fréquentes.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_006 audité

Q29 EX DX.10 · diarrhée sanglante fébrile

✅ **B** — Coproculture ou PCR, sans lopéramide

① **Pourquoi c'est juste** Sang dans les selles et fièvre élevée : entérite invasive à documenter par coproculture ou PCR (DX.10). Le lopéramide est contre-indiqué, et l'on écarte une colite ou un EHEC avant tout traitement.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiqué dans l'entérite invasive fébrile.
- **C** Il ne répond pas au problème et n'a pas d'indication AIPS ici.
- **D** Pas d'antibiotique avant d'écarter un EHEC.
- **E** Elle n'est pas le premier examen.

③ **Perle** La réhydratation reste le traitement principal.

④ **Source** Phase B DX.10 §10 · LOT_006 audité

Q30 EX DX.8 vs DX.5 · ganglions et fièvre

✅ **A** — Biopsie ganglionnaire

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre prolongée, sueurs nocturnes, perte de poids et adénopathie : néoplasie, surtout lymphome, à prouver par l'histologie (DX.8). On biopsie la lésion accessible ; aucun corticoïde avant la biopsie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Sans histologie, elle masque un lymphome.
- **C** Il retarde le diagnostic chez un patient stable.
- **D** Les signes généraux imposent un diagnostic rapide.
- **E** Ils ne posent pas le diagnostic de néoplasie.

③ **Perle** FUO néoplasique : mortalité de 38 % à 6 mois, la plus élevée.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_006 audité

Q31 EX DX.3 · cellulite simple

✅ **D** — Bêtalactamine orale, limites marquées, contrôle à 48 h

① **Pourquoi c'est juste** Cellulite non purulente stable : bêtalactamine orale active sur le streptocoque, limites marquées au feutre, élévation du membre et traitement de la porte d'entrée, contrôle à 48 h (DX.3).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Forme non compliquée et stable : traitement ambulatoire.
- **B** Rarement positives dans la cellulite simple.
- **C** Conduite de la dermite de stase, pas de la cellulite.
- **E** Aucun signe de fasciite nécrosante.

③ **Perle** Traiter 5 jours si l'amélioration est nette (IDSA).

④ **Source** Phase B DX.3 §13 · LOT_006 audité

Q32 EX DX.1 vs DX.9 · radiographie normale

✅ **E** — TDM thoracique ou nouvelle radiographie

① **Pourquoi c'est juste** Au début d'une pneumonie, la radiographie peut sembler normale (DX.1). Si la clinique est évocatrice, on répète l'imagerie ou l'on demande une TDM avant de conclure à une autre cause (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La radiographie peut être normale au début ; la clinique prime.
- **B** Elle n'explore pas une condensation.
- **C** Examen invasif sans indication de première ligne.
- **D** Rien n'oriente vers une cause cardiaque.

③ **Perle** Le diagnostic exige une opacité nouvelle : c'est le critère décisif.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_006 audité

Q33 AP DX.1 · critère décisif

✅ **C** — Opacité nouvelle à la radiographie

① **Pourquoi c'est juste** La pneumonie associe un symptôme respiratoire aigu, un signe infectieux et une opacité nouvelle à l'imagerie (DX.1). L'opacité est le critère décisif, car la clinique seule manque de précision.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une CRP élevée seule ne pose pas le diagnostic.
- **B** Il mesure la gravité, pas le diagnostic.
- **D** La fièvre seule ne pose pas le diagnostic.
- **E** Un crépitant isolé ne suffit pas.

③ **Perle** Le score de gravité choisit le lieu de traitement, il ne pose pas le diagnostic.

④ **Source** Phase B DX.1 §8 · LOT_006 audité

Q34 SPE · Médecine intensive DX.1 · hydrocortisone en soins intensifs

✅ **A** — Hydrocortisone 200 mg/j i.v.

① **Pourquoi c'est juste** Dans l'essai CAPE COD (Dequin, NEJM 2023), l'hydrocortisone 200 mg/j i.v. pendant 4 à 8 jours, puis réduite, abaisse la mortalité à 28 jours de 11,9 % à 6,2 % (DX.1). Hors AIPS : à valider avec un spécialiste.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Schéma de la méningite bactérienne.
- **C** Antiviral de la grippe, non évalué dans cet essai.
- **D** Indiqué selon l'hématologie dans la neutropénie, pas ici.
- **E** Schéma de l'artérite avec perte visuelle.

③ **Perle** Indication limitée aux formes graves en soins intensifs.

④ **Source** Phase B DX.1 §11 · LOT_006 audité

Q35 EX DX.2 · pyélonéphrite et grossesse

✅ **C** — Hospitalisation et ceftriaxone i.v.

① **Pourquoi c'est juste** Pyélonéphrite pendant la grossesse : forme compliquée (DX.2). Hospitalisation, ceftriaxone i.v. et avis obstétrical ; la ciprofloxacine est contre-indiquée selon l'AIPS.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiquée pendant la grossesse (AIPS).
- **B** Toute la classe des fluoroquinolones est évitée pendant la grossesse.
- **D** Traitement de la cystite, pas de la pyélonéphrite.
- **E** À éviter pendant la grossesse.

③ **Perle** Le piège : croire les autres fluoroquinolones permises ; on choisit une bêtalactamine.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_006 audité

Q36 EX DX.2 · fièvre persistante à 72 h

✅ **A** — Échographie ou TDM des voies urinaires

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre persistante après 72 heures d'antibiotique adapté : imagerie (échographie ou TDM) à la recherche d'une obstruction ou d'un abcès (DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le germe est sensible : on cherche d'abord un foyer non drainé.
- **C** L'infection n'est pas contrôlée.
- **D** L'antipyrétique ne ferme aucune branche dangereuse.
- **E** Elle n'explique pas l'échec.

③ **Perle** Une obstruction infectée exige un drainage.

④ **Source** Phase B DX.2 §13 · LOT_006 audité

**Q37** **EX** **DX.3 vs pseudo-cellulite**

✅ **E** — Dermite de stase

① **Pourquoi c'est juste** Rougeur bilatérale, froide, sans fièvre : pseudo-cellulite, en premier lieu la dermite de stase (DX.3). Compression et soins cutanés, sans antibiotique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une cellulite bilatérale, froide et sans fièvre est improbable.
- **B** Aucune douleur disproportionnée ni signe systémique.
- **C** Aucun argument cardiaque ni fièvre.
- **D** Rougeur chronique froide bilatérale : imitateur cutané plus probable.

③ **Perle** Dermite de stase, eczéma et lymphœdème expliquent 54 % des erreurs devant une jambe rouge.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_006 audité

**Q38** **AP** **DX.3 · LRINEC bas**

✅ **A** — Un score bas n'exclut pas la fasciite

① **Pourquoi c'est juste** Le LRINEC (leucocytes, hémoglobine, sodium, glucose, créatinine, CRP) a montré une VPP de 92 % et une VPN de 96 % au seuil de 6 dans sa cohorte, mais un score bas n'exclut pas la fasciite nécrosante (DX.3). La douleur disproportionnée impose l'avis chirurgical.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** La valeur prédictive négative de la cohorte de développement ne s'applique pas au cas clinique évocateur.
- **C** Il ne confirme pas la cellulite.
- **D** La clinique l'emporte sur le score.
- **E** Attendre un nouveau calcul retarde la chirurgie.

③ **Perle** Signe d'appel principal : douleur disproportionnée aux signes cutanés.

④ **Source** Phase B DX.3 §8 · LOT_006 audité

**Q39** **SPE · Infectiologie** **DX.3 · allergie aux bêtalactamines**

✅ **A** — Clindamycine per os

① **Pourquoi c'est juste** En cas d'allergie aux bêtalactamines, la clindamycine est l'alternative : 600 à 1200 mg/j per os en 3 ou 4 prises (AIPS Dalacin® C) (DX.3).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Contre-indiquée en cas d'allergie aux pénicillines.
- **C** Pénicilline : contre-indiquée.
- **D** Pénicilline : contre-indiquée.
- **E** Risque croisé après une anaphylaxie aux bêtalactamines.

③ **Perle** La clindamycine bloque aussi la production de toxines dans les formes nécrosantes.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_006 audité

**Q40** **EX** **DX.4 · 10 jours de fièvre**

✅ **B** — Ce n'est pas encore une FUO

① **Pourquoi c'est juste** La FUO exige au moins 3 semaines de fièvre, 38,3 °C documentés deux fois, l'absence d'immunosuppression et un bilan de base négatif (DX.4). À 10 jours, on réévalue et on surveille.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La FUO exige 3 semaines ou plus et un bilan de base négatif.
- **C** Ni la définition ni la conduite ne sont remplies.
- **D** Rien n'indique une immunosuppression.
- **E** Rien ne permet de l'affirmer.

③ **Perle** La durée seule ne suffit pas, une fièvre non objectivée non plus.

④ **Source** Phase B DX.4 §8 · LOT_006 audité

**Q41** **AP** **DX.4 · corticothérapie au long cours**

✅ **E** — Le corticoïde ≥ 10 mg/j l'immunodéprime

① **Pourquoi c'est juste** Critère d'immunité de la FUO : VIH négatif, immunoglobulines normales, pas de neutropénie, pas de corticoïde ≥ 10 mg de prednisone par jour (DX.4). Sinon, prise en charge de l'immunodéprimé.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle dépasse 3 semaines.
- **B** Il a été fait et il est négatif.
- **C** Rien ne l'indique.
- **D** L'âge n'est pas un critère d'exclusion.

③ **Perle** L'immunodéprimé fébrile suit une autre démarche, plus urgente.

④ **Source** Phase B DX.4 §8 · LOT_006 audité

**Q42** **AP** **DX.4 · VS et CRP normales**

✅ **D** — Objectiver la fièvre devant témoin

① **Pourquoi c'est juste** Si la VS et la CRP sont normales, le PET n'a aidé aucun patient dans l'étude néerlandaise (DX.4). On objective la mesure devant témoin et l'on recherche une fièvre factice ou une fièvre périodique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Avec VS et CRP normales, le TEP est peu utile.
- **B** Aucune piste ne l'oriente.
- **C** Il masque la cause.
- **E** Elle masque la cause.

③ **Perle** Fièvre factice : température simulée ou provoquée, à mesurer devant témoin.

④ **Source** Phase B DX.4 §10 · LOT_006 audité

**Q43** **EX** **DX.5 vs DX.8 · pics quotidiens et éruption**

✅ **E** — Exclure infection et cancer

① **Pourquoi c'est juste** Maladie de Still de l'adulte : 5 critères de Yamaguchi dont 2 majeurs (sensibilité 96,2 %, spécificité 92,1 %), mais diagnostic d'exclusion : infection et cancer doivent être écartés (DX.5, DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les critères ne suffisent pas sans exclusion des infections et des cancers.
- **B** L'artérite à cellules géantes exige un âge ≥ 50 ans.
- **C** Il masque une cause infectieuse.
- **D** Sans voyage, rien ne l'oriente.

③ **Perle** Maladie inflammatoire non infectieuse : 22 % des FUO néerlandaises.

④ **Source** Phase B DX.5 §13 · LOT_006 audité

**Q44** **EX** **DX.5 · premier examen de l'ACG**

✅ **E** — Échographie des artères temporales et axillaires

① **Pourquoi c'est juste** En cas de suspicion d'artérite à cellules géantes, l'échographie des artères temporales et axillaires vient en premier ; le signe du halo vaut 5 points dans la classification ACR/EULAR 2022 (DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Examen invasif sans place en première intention.
- **B** Il ne montre pas l'artérite.
- **C** Elle n'explore pas les artères.
- **D** Sans rapport avec la question.

③ **Perle** L'échographie ou la biopsie s'organise dans les jours qui suivent, sans retarder la prednisone.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_006 audité

**Q45** **AP** **DX.5 · seuils de classification**

✅ **A** — CRP ≥ 10 mg/L ou VS ≥ 50 mm/h

① **Pourquoi c'est juste** Critères ACR/EULAR 2022 : âge ≥ 50 ans obligatoire ; biopsie positive ou halo +5 ; VS ≥ 50 mm/h ou CRP ≥ 10 mg/L +3 ; perte visuelle soudaine +3. Un score ≥ 6 classe l'ACG (DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Seuils trop élevés : ce ne sont pas ceux du score.
- **C** Évoque plutôt une maladie de Still ou un syndrome d'activation macrophagique.
- **D** Ce n'est pas un critère du score.
- **E** Marqueur d'infection bactérienne, hors du score.

③ **Perle** Ce sont des critères de classification pour la recherche : ils ne remplacent pas le jugement clinique.

④ **Source** Phase B DX.5 §8 · LOT_006 audité

**Q46** **SPE · Rhumatologie** **DX.5 · ferritine et cytopénies**

✅ **B** — Soins intensifs, avis hématologique et rhumatologique

① **Pourquoi c'est juste** Cytopénies et ferritine très élevée chez un patient atteint de Still : suspicion de syndrome d'activation macrophagique (MAS). Hospitalisation en soins intensifs, avis de l'hématologue et du rhumatologue (DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Traitement du Still léger, inadapté à une complication grave.
- **C** Traitement de fond, pas de l'urgence.
- **D** Le syndrome menace la vie.
- **E** Sans rapport avec le tableau.

③ **Perle** Le MAS est la complication grave à reconnaître dans le Still.

④ **Source** Phase B DX.5 §10 · LOT_006 audité

**Q47** **EX** **DX.6 · Riamet® non compliqué**

✅ **B** — 4 cp à 0 et 8 h, puis 4 cp 2×/j 2 jours, avec des lipides

① **Pourquoi c'est juste** Riamet® (AIPS) : 4 comprimés au diagnostic, 4 comprimés 8 h plus tard, puis 4 deux fois par jour pendant 2 jours, soit 24 comprimés, avec un aliment contenant des lipides (DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose très insuffisante.
- **C** Cure incomplète : 24 comprimés en 3 jours.
- **D** Schéma de Malarone® ; Riamet® se prend avec des lipides.
- **E** Schéma inexact.

③ **Perle** Le P. falciparum non compliqué s'hospitalise pour observation et pour la première dose.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_006 audité

**Q48** **AP** **DX.6 · seuil d'hyperparasitémie**

✅ **A** — Hyperparasitémie non compliquée

① **Pourquoi c'est juste** Selon l'OMS 2023, une hyperparasitémie ≥ 10 % des globules rouges est un critère de gravité ; de 4 à 10 %, c'est une hyperparasitémie non compliquée (DX.6). Créatinine > 3 mg/dL, oligo-anurie, lactate ≥ 5 mmol/L et confusion prédisent la forme critique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le seuil de gravité de la parasitémie est ≥ 10 %.
- **C** L'espèce est P. falciparum.
- **D** Entre 4 et 10 %, on parle d'hyperparasitémie.
- **E** Elle est consciente.

③ **Perle** La surveillance de la parasitémie continue jusqu'à sa négativation.

④ **Source** Phase B DX.6 §8 · LOT_006 audité

Q49 SPE · Médecine tropicale DX.6 · P. vivax

✅ **B** — Doser la G6PD, puis traiter les hypnozoïtes

① **Pourquoi c'est juste** P. vivax et P. ovale rechutent à partir des hypnozoïtes hépatiques (DX.6). Après l'accès sanguin, un traitement contre les hypnozoïtes suit, après dosage de la G6PD.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Riamet® agit sur les formes sanguines, pas sur les hypnozoïtes.
- **C** Réservé au paludisme grave.
- **D** Ce n'est pas le traitement des formes dormantes.
- **E** Aucune indication.

③ **Perle** Le dosage de la G6PD précède le traitement des formes hépatiques.

④ **Source** Phase B DX.6 §10 · LOT_006 audité

Q50 EX DX.7 · antipyrétique

✅ **C** — Paracétamol, 4 g/j au maximum

① **Pourquoi c'est juste** Dengue : paracétamol et hydratation ; l'aspirine et les AINS sont à éviter (risque hémorragique, recommandation OMS) (DX.7). Paracétamol 500 à 1000 mg par prise, au plus 4 g/j chez l'adulte.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les AINS augmentent le risque hémorragique.
- **B** L'aspirine est à éviter dans la dengue.
- **D** Réservé à la forte fièvre qui résiste, avec risque d'agranulocytose.
- **E** AINS : à éviter.

③ **Perle** Le patient reçoit la liste écrite des signes d'alarme et reconsulte s'ils apparaissent.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_006 audité

**Q51** **EX** **DX.7 · RT-PCR négative au 9e jour**

✅ **B** — IgM antidengue

① **Pourquoi c'est juste** RT-PCR et NS1 confirment la dengue dans les 7 premiers jours (DX.7). Après, on dose les IgM, détectables dès le 4e jour ; une IgM sur un seul sérum signe une dengue probable.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Après le 7e jour, la virémie baisse et la RT-PCR perd sa sensibilité.
- **C** Les IgG persistent à vie et ne datent pas l'infection.
- **D** La virémie aura encore baissé.
- **E** Utile dans les 7 premiers jours.

③ **Perle** Réactions croisées entre flavivirus : une IgM isolée ne donne pas la certitude.

④ **Source** Phase B DX.7 §8 · LOT_006 audité

**Q52** **AP** **DX.7 · pression normale**

✅ **A** — Pression pulsée étroite : choc débutant

① **Pourquoi c'est juste** Dans la dengue, le choc se reconnaît d'abord par une pression pulsée étroite, une tachycardie et une recoloration lente, avant l'hypotension (DX.7). On traite alors comme une dengue sévère.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** La pression pulsée se rétrécit avant l'effondrement de la systolique.
- **C** La pression pulsée étroite oriente vers la fuite plasmatique.
- **D** La diastolique élevée traduit la vasoconstriction.
- **E** La phase critique n'est pas terminée.

③ **Perle** Un choc reconnu tôt et traité diminue la mortalité d'au moins 20 fois.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_006 audité

Q53 AP DX.7 · IgG positives

✅ **D** — Elles ne posent pas un diagnostic aigu

① **Pourquoi c'est juste** Les IgG persistent à vie et réagissent avec les autres flavivirus et leurs vaccins : elles ne servent pas au diagnostic aigu (DX.7). Avant le 7e jour, on demande la RT-PCR ou le NS1.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les IgG persistent à vie.
- **B** Elles ne disent rien de l'épisode actuel.
- **C** Aucune valeur pronostique ici.
- **E** Le paludisme se teste toujours le jour même.

③ **Perle** RT-PCR ou NS1 positifs ne prédisent pas la gravité.

④ **Source** Phase B DX.7 §8 · LOT_006 audité

Q54 SPE · Médecine intensive DX.7 · choc de dengue

✅ **A** — Pas de plaquettes préventives ni de corticoïdes

① **Pourquoi c'est juste** Choc de dengue : cristalloïde isotonique au volume minimal, diurèse cible ≥ 0,5 mL/kg/h ; transfusion de globules rouges seulement si saignement actif ; ni plaquettes préventives ni corticoïdes (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Elle favorise la surcharge liquidienne sans bénéfice.
- **C** Les corticoïdes ne sont pas indiqués.
- **D** Le cristalloïde isotonique est la référence.
- **E** On donne le volume minimal qui restaure la perfusion.

③ **Perle** Les perfusions ne durent habituellement que 24 à 48 h, pendant la phase critique.

④ **Source** Phase B DX.7 §11 · LOT_006 audité

**Q55** **EX** **DX.8 · captation au TEP**

✅ **C** — Biopsie de la zone captante

① **Pourquoi c'est juste** Le FDG-PET/CT localise une zone à biopsier mais ne prouve pas la néoplasie : la captation vaut aussi pour l'inflammation et l'infection (DX.8). L'histologie seule pose le diagnostic.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans histologie, la néoplasie n'est pas prouvée.
- **B** La captation vaut aussi pour l'inflammation et l'infection.
- **D** Elle masque l'histologie.
- **E** Retarde le diagnostic.

③ **Perle** Rendement du TEP précoce dans la FUO : 40 à 60 %.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_006 audité

**Q56** **EX** **DX.8 vs DX.14 · fièvre après chimiothérapie**

✅ **C** — Neutropénie fébrile, pas une FUO

① **Pourquoi c'est juste** Un patient neutropénique n'entre pas dans la FUO (DX.8) : il relève de la neutropénie fébrile, avec antibiotique i.v. dans l'heure (DX.14).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La neutropénie exclut la définition de la FUO.
- **B** Le critère d'immunité n'est pas rempli.
- **D** Rien ne l'oriente.
- **E** La neutropénie domine le tableau.

③ **Perle** Après 4 à 7 jours de fièvre sous antibiotique, on cherche une infection fongique.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_006 audité

**Q57** **AP** **DX.8 · test au naproxène**

✅ **B** — Il oriente, sans prouver la néoplasie

① **Pourquoi c'est juste** Le test au naproxène oriente vers une fièvre néoplasique plutôt qu'infectieuse, mais il ne remplace pas l'histologie, et aucune sensibilité n'est chiffrée dans les sources lues (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Seule l'histologie le pose.
- **C** Il ne la remplace pas.
- **D** Aucune sensibilité chiffrée ne l'autorise.
- **E** Il soulage, sans traiter la cause.

③ **Perle** Naproxène contre-indiqué si la clairance est < 30 mL/min (AIPS).

④ **Source** Phase B DX.8 §13 · LOT_006 audité

**Q58** **AP** **DX.8 · pics fébriles élevés**

✅ **E** — Cancer du rein et lymphomes

① **Pourquoi c'est juste** Le cancer du rein et les lymphomes donnent classiquement des pics fébriles élevés ; les leucémies, les syndromes myéloprolifératifs et le myélome n'en donnent habituellement pas (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il ne donne habituellement pas de fièvre aiguë.
- **B** Ils n'en donnent habituellement pas.
- **C** Les leucémies n'en donnent habituellement pas.
- **D** Il n'est pas cité parmi les causes de pics fébriles.

③ **Perle** Néoplasie : 7 à 15 % des FUO selon les séries lues.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_006 audité

Q59 EX DX.9 · adulte sain

✅ **C** — Traitement symptomatique, sans PCR obligatoire

① **Pourquoi c'est juste** Grippe non compliquée de l'adulte sain : traitement symptomatique à domicile ; l'antiviral se décide selon le risque (DX.9). On teste si le résultat change la prise en charge.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Chez l'adulte sain, le résultat ne change pas la prise en charge.
- **B** Les antibiotiques ne traitent pas la grippe.
- **D** Forme non compliquée chez un adulte sain.
- **E** Aucun signe de pneumonie.

③ **Perle** Avant de conclure à la grippe, chercher sepsis, pneumonie et méningite.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_006 audité

Q60 AP DX.9 · grippe sans fièvre

✅ **D** — L'absence de fièvre n'exclut pas la grippe

① **Pourquoi c'est juste** Chez la personne âgée, la grippe survient parfois sans fièvre (DX.9). La PCR sur frottis nasopharyngé confirme Influenza A ou B.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Chez la personne âgée, la grippe survient parfois sans fièvre.
- **B** Le résultat peut changer la prise en charge (antiviral, isolement).
- **C** Elle peut en être le signe.
- **E** La PCR sur frottis nasopharyngé fait le diagnostic.

③ **Perle** Syndrome grippal ECDC 2018 : sensible mais non spécifique.

④ **Source** Phase B DX.9 §8 · LOT_006 audité

**Q61** **AP** **DX.9 · clairance 45 mL/min**

✅ **D** — 30 mg 2×/j pendant 5 jours

① **Pourquoi c'est juste** Oseltamivir (AIPS Tamiflu®) : clairance de 30 à 60 mL/min → 30 mg deux fois par jour ; de 10 à 30 mL/min → 30 mg une fois par jour (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose de la fonction rénale normale.
- **B** Dose d'une clairance de 10 à 30 mL/min.
- **C** Schéma de la prophylaxie après contact.
- **E** Dose excessive.

③ **Perle** Débuter dans les 36 premières heures si possible.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_006 audité

**Q62** **SPE · Infectiologie** **DX.9 · baloxavir**

✅ **B** — 40 mg en dose unique dans les 48 h

① **Pourquoi c'est juste** Baloxavir (Xofluza®, AIPS) : dose unique dans les 48 h, 40 mg de 20 à moins de 80 kg, 80 mg dès 80 kg ; éviter calcium, laitages et antiacides pris en même temps (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose réservée aux patients de 80 kg ou plus.
- **C** Le baloxavir se donne en une seule prise.
- **D** Schéma de l'oseltamivir.
- **E** Schéma inexact.

③ **Perle** Délai médian d'amélioration : 53,7 h contre 80,2 h sous placebo.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_006 audité

**Q63** **EX** **DX.10 · vomissements bilieux**

✅ **D** — Imagerie et avis chirurgical en urgence

① **Pourquoi c'est juste** Des vomissements bilieux ne sont pas une gastro-entérite : urgence abdominale, échographie et avis chirurgical (DX.10). Avant de conclure à une gastro-entérite, on exclut un abdomen chirurgical.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Des vomissements bilieux évoquent une urgence abdominale.
- **B** Il masquerait une urgence chirurgicale.
- **C** Elle ne répond pas à la question urgente.
- **E** Retarde le diagnostic.

③ **Perle** Douleur localisée, défense ou vomissements bilieux : arbre décisionnel N1.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_006 audité

**Q64** **AP** **DX.10 · ondansétron**

✅ **E** — Pas d'indication AIPS dans la gastro-entérite

① **Pourquoi c'est juste** L'AIPS de l'ondansétron cite la chimiothérapie, la radiothérapie et les nausées postopératoires, pas la gastro-entérite (DX.10). L'arbre propose de le discuter si les vomissements empêchent l'apport oral.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** C'est un antiémétique, pas un antidiarrhéique.
- **B** La réhydratation reste le traitement principal.
- **C** Ce n'est pas la règle citée : l'interdit sous 6 ans vise le lopéramide.
- **D** On le discute seulement si les vomissements empêchent l'apport oral.

③ **Perle** L'enfant qui vomit reçoit d'abord de petites quantités fréquentes.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_006 audité

Q65 SPE · Néphrologie DX.10 · EHEC suspecté

✅ **B** — Hospitaliser, sans antidiarrhéique ni antibiotique

① **Pourquoi c'est juste** Entérite sanglante avec anémie, thrombopénie et atteinte rénale : syndrome hémolytique et urémique suspect (DX.10). Arrêter tout antidiarrhéique, éviter les AINS, pas d'antibiotique avant l'avis ; hospitaliser, surveiller diurèse et créatinine, avis néphrologique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les antidiarrhéiques sont proscrits dans l'entérite sanglante à EHEC.
- **C** Pas d'antibiotique avant l'avis spécialisé.
- **D** Les AINS sont à éviter.
- **E** Elle n'est pas indiquée.

③ **Perle** Créatinine et diurèse se contrôlent chaque jour.

④ **Source** Phase B DX.10 §11 · LOT_006 audité

Q66 AP DX.11 · définition Sepsis-3

✅ **C** — Infection et hausse du SOFA ≥ 2 points

① **Pourquoi c'est juste** Sepsis-3 (2016) : infection suspectée ou prouvée et hausse du SOFA ≥ 2 points par rapport à la base (DX.11). Ici, plaquettes < 100 G/L (2 points) et Glasgow 13 (1 point) : SOFA à 3.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le SIRS seul ne pose pas le sepsis.
- **B** Le qSOFA ne pose ni n'exclut le sepsis.
- **D** Sans dysfonction d'organe, c'est une bactériémie.
- **E** Une CRP élevée seule ne suffit pas.

③ **Perle** SOFA ≥ 2 : mortalité hospitalière > 10 %.

④ **Source** Phase B DX.11 §8 · LOT_006 audité

Q67 AP DX.11 · bactériémie ou sepsis

✅ **D** — Bactériémie sans sepsis

① **Pourquoi c'est juste** Une hémoculture positive sans dysfonction d'organe est une bactériémie, pas un sepsis (DX.11). Inversement, des hémocultures négatives n'excluent pas le sepsis.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il manque la dysfonction d'organe.
- **B** Aucun vasopresseur ni lactate élevé.
- **C** Une hémoculture isolée à E. coli ne remplit pas les critères.
- **E** E. coli n'est pas un contaminant cutané habituel.

③ **Perle** Le sepsis est une dysfonction d'organe par réponse dérégulée à l'infection.

④ **Source** Phase B DX.11 §8 · LOT_006 audité

Q68 SPE · Médecine intensive DX.11 · vasopresseur persistant

✅ **C** — Hydrocortisone

① **Pourquoi c'est juste** Si la pression reste basse sous noradrénaline : vasopressine, puis adrénaline, et l'on envisage l'hydrocortisone (DX.11). Elle n'est pas de routine : l'AIPS ne la recommande pas en usage systématique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Schéma de la méningite à pneumocoque.
- **B** La SSC 2021 la déconseille pour cette décision.
- **D** Le foyer n'est pas contrôlé.
- **E** Elle ne répond pas au besoin de vasopresseur.

③ **Perle** Contrôle du foyer dans les 6 à 12 heures ; soins intensifs dans les 6 heures.

④ **Source** Phase B DX.11 §11 · LOT_006 audité

Q69 AP DX.11 · procalcitonine

✅ **E** — Antibiotique sans attendre la procalcitonine

① **Pourquoi c'est juste** La procalcitonine ne décide pas du début de l'antibiotique (SSC 2021) (DX.11). En cas de sepsis probable, l'antibiotique se donne dans l'heure ; en cas de sepsis possible sans choc, dans les 3 heures.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La SSC 2021 la déconseille pour décider du début de l'antibiotique.
- **B** Le retard aggrave le pronostic.
- **C** On prélève sans attendre le résultat.
- **D** Le foyer se cherche en parallèle.

③ **Perle** Une procalcitonine élevée seule ne pose pas le sepsis.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_006 audité

Q70 EX DX.12 · après 50 ans

✅ **E** — Ampicilline ou amoxicilline i.v.

① **Pourquoi c'est juste** Listeria monocytogenes n'est pas couvert par les céphalosporines (DX.12). Après 50 ans ou en cas d'immunodépression, on ajoute l'ampicilline ou l'amoxicilline i.v. à la ceftriaxone.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il s'ajoute seulement si une encéphalite herpétique reste possible.
- **B** Elle n'est pas le complément de la ceftriaxone ici.
- **C** Elle ne couvre pas Listeria.
- **D** Les céphalosporines ne couvrent pas Listeria.

③ **Perle** La DGN 2023 retient ceftriaxone plus ampicilline comme schéma empirique de l'adulte.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_006 audité

**Q71** **EX** **DX.12 · contact étroit**

✅ **D** — Son colocataire du même appartement

① **Pourquoi c'est juste** Contact étroit : même foyer, contact intense avec les sécrétions, partenaire de sport très proche (DX.12). La proximité d'un train ou d'un avion ne suffit pas.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La proximité d'un train ne suffit pas.
- **B** Pas de contact intense avec les sécrétions.
- **C** Il ne partage pas le foyer.
- **E** La proximité d'un avion ne suffit pas.

③ **Perle** Déclarer tout cas de méningocoque dans les 24 heures (OFSP).

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_006 audité

**Q72** **AP** **DX.12 · LCR peu cellulaire**

✅ **E** — Méningite bactérienne probable

① **Pourquoi c'est juste** Jusqu'à un tiers des méningites à pneumocoque ont moins de 1000 cellules/µL (33 % dans une série de 1816 patients) (DX.12). Neutrophiles, protéines > 1 g/L, quotient glucose < 0,3 et lactate > 3,5 mmol/L signent l'origine bactérienne.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Lactate > 3,5 mmol/L, glucose abaissé et neutrophiles orientent vers une cause bactérienne.
- **B** Il est nettement pathologique.
- **C** La cytologie est mixte dans la tuberculose ; rien ne la prouve.
- **D** Le profil est inflammatoire.

③ **Perle** L'absence de raideur de nuque n'exclut pas non plus la méningite.

④ **Source** Phase B DX.12 §8 · LOT_006 audité

**Q73** **SPE · Infectiologie** DX.12 · contact enceinte

✅ **E** — Ceftriaxone 250 mg i.m. en dose unique

① **Pourquoi c'est juste** Chez la femme enceinte contact étroit, la prophylaxie est la ceftriaxone 250 mg i.m. en dose unique (BAG 2025) ; ciprofloxacine et rifampicine sont déconseillées (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Déconseillée pendant la grossesse.
- **B** Déconseillée pendant la grossesse.
- **C** Elle est contact étroit.
- **D** Il ne remplace pas la prophylaxie immédiate.

③ **Perle** La rifampicine réduit aussi l'efficacité des contraceptifs hormonaux.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_006 audité

**Q74** **EX** DX.13 · indication opératoire urgente

✅ **A** — Chirurgie dans les 24 heures

① **Pourquoi c'est juste** Œdème pulmonaire ou choc par régurgitation, obstruction ou fistule : opération d'urgence dans les 24 heures (ESC 2023) (DX.13). Insuffisance cardiaque ou abcès : urgente dans les 3 à 5 jours.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'œdème pulmonaire impose une chirurgie d'urgence.
- **C** Délai incompatible avec le pronostic.
- **D** La valve détruite ne guérit pas par l'antibiotique seul.
- **E** On n'attend pas en cas d'œdème pulmonaire.

③ **Perle** Pas d'anticoagulant en cas de déficit neurologique avant l'imagerie.

④ **Source** Phase B DX.13 §11 · LOT_006 audité

Q75 AP DX.13 · critères de Duke

✅ **E** — Certaine : deux critères majeurs

① **Pourquoi c'est juste** Duke-ISCVID 2023 : certain = deux critères majeurs, ou un majeur et trois mineurs, ou cinq mineurs (DX.13). Germe typique dans au moins deux hémocultures et végétation à l'échocardiographie sont deux majeurs.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il y a deux critères majeurs.
- **B** L'absence de souffle n'exclut pas.
- **C** Microbiologie et imagerie sont des critères majeurs.
- **D** L'inspection chirurgicale n'est pas indispensable.

③ **Perle** Les critères guident ; la décision finale revient à l'équipe de l'endocardite.

④ **Source** Phase B DX.13 §8 · LOT_006 audité

Q76 SPE · Infectiologie DX.13 · SARM du cœur droit

✅ **E** — Daptomycine 6 mg/kg/24 h i.v.

① **Pourquoi c'est juste** SARM de l'endocardite droite : daptomycine 6 mg/kg i.v. toutes les 24 h pendant 2 à 6 semaines, ou vancomycine selon l'AIPS (DX.13). La CPK se dose avant puis chaque semaine.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Inactive sur le SARM.
- **B** Inactive sur le SARM.
- **C** Inactive sur le SARM.
- **D** Ce n'est pas un traitement de l'endocardite.

③ **Perle** La daptomycine n'est établie par l'AIPS que pour l'endocardite droite, pas gauche.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_006 audité

Q77 SPE · Cardiologie DX.13 · aminoside sur valve native

✅ **C** — Non, pas d'aminoside sur valve native

① **Pourquoi c'est juste** Endocardite à SASM sur valve native : flucloxacilline 12 g/j en perfusions de 2 g au plus ; pas d'aminoside selon l'ESC 2023, car la gentamicine est néphrotoxique (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Néphrotoxique, sans bénéfice sur valve native selon l'ESC 2023.
- **B** La flucloxacilline reste le traitement du SASM.
- **D** Ce n'est pas le critère retenu.
- **E** Aucune indication systématique.

③ **Perle** L'équipe d'endocardite décide selon la valve (native ou prothétique) et le germe.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_006 audité

Q78 EX DX.14 · faible risque

✅ **C** — Antibiotique oral en ambulatoire

① **Pourquoi c'est juste** Un score MASCC ≥ 21 identifie un faible risque : chez un patient fiable, un traitement oral ambulatoire est possible, par exemple une fluoroquinolone avec l'amoxicilline-acide clavulanique (DX.14).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le score indique un faible risque.
- **B** La neutropénie fébrile se traite toujours.
- **D** Réservé à la fièvre persistante au-delà de 4 à 7 jours.
- **E** Il ne remplace pas l'antibiotique.

③ **Perle** MASCC ≥ 21 : VPP 91 %, spécificité 68 %, sensibilité 71 %.

④ **Source** Phase B DX.14 §8 · LOT_006 audité

**Q79** **SPE · Hématologie** **DX.14 vs DX.4 · fièvre persistante**

✅ **E** — Une infection fongique

① **Pourquoi c'est juste** Après 4 à 7 jours de fièvre persistante sous antibiotique, on cherche une infection fongique : scanner thoracique, marqueurs fongiques, antifongique empirique selon l'hématologue (DX.14).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Rien ne l'oriente.
- **B** Aucun contexte de chaleur.
- **C** La neutropénie exclut la FUO.
- **D** Diagnostic d'exclusion hors de propos ici.

③ **Perle** Réévaluer à 48–72 h, puis à nouveau si la fièvre persiste.

④ **Source** Phase B DX.14 §13 · LOT_006 audité

**Q80** **SPE · Hématologie** **DX.14 · cathéter infecté**

✅ **C** — Vancomycine

① **Pourquoi c'est juste** Foyer de cathéter, instabilité, pneumonie ou peau : ajouter la vancomycine à la bêtalactamine antipseudomonale (DX.14). La vancomycine se dose sur le creux sérique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle ne couvre pas les staphylocoques résistants du cathéter.
- **B** Il vise les anaérobies abdominaux.
- **D** Antiviral sans rapport.
- **E** Le foyer de cathéter impose de couvrir les germes résistants.

③ **Perle** Abdomen : couvrir les anaérobies.

④ **Source** Phase B DX.14 §10 · LOT_006 audité

**Q81** **AP** **DX.14 · CRP normale**

✅ **A** — La CRP normale ne rassure pas

① **Pourquoi c'est juste** Le neutropénique ne fait pas de réponse inflammatoire locale : l'absence de foyer n'exclut rien et une CRP normale ne rassure pas (DX.14). Hémocultures puis antibiotique i.v. dans l'heure.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Sans neutrophiles, la réponse inflammatoire manque.
- **C** Les signes locaux sont absents chez le neutropénique.
- **D** Attribution prématurée.
- **E** L'antibiotique i.v. se donne dans l'heure.

③ **Perle** Sans neutrophiles, une infection bactérienne progresse et tue en quelques heures.

④ **Source** Phase B DX.14 §8 · LOT_006 audité

**Q82** **EX** **DX.15 vs DX.11 · épuisement par la chaleur**

✅ **E** — Épuisement par la chaleur

① **Pourquoi c'est juste** Symptômes de chaleur sans atteinte neurologique, température plus basse : épuisement par la chaleur, à traiter par repos au frais et boissons en surveillant l'évolution (DX.15).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il faut une température > 40 °C avec un trouble neurologique.
- **B** Aucun signe méningé ni fièvre élevée.
- **C** Aucun foyer ni dysfonction d'organe.
- **D** Aucun voyage.

③ **Perle** Un coup de chaleur au travail peut relever de la LAA et de la Suva.

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_006 audité

Q83 EX DX.15 · site de mesure

✅ **B** — Mesurer la température rectale

① **Pourquoi c'est juste** Le coup de chaleur se diagnostique sur la température centrale : on la mesure au rectum, et on la répète toutes les 5 minutes pendant le refroidissement (DX.15). Les mesures buccale, tympanique et cutanée sous-estiment.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle sous-estime la température centrale.
- **C** Elle sous-estime aussi la valeur.
- **D** La peau peut rester moite dans la forme d'effort.
- **E** Aucun examen n'est nécessaire pour décider de refroidir.

③ **Perle** Une confusion après effort dans la chaleur impose de refroidir sans attendre les examens.

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_006 audité

Q84 AP DX.15 vs DX.1 · hyperthermie ou fièvre

✅ **C** — Consigne hypothalamique normale

① **Pourquoi c'est juste** Dans la fièvre, IL-1, IL-6 et TNF-α induisent la COX-2, la PGE2 agit sur les récepteurs EP3 et relève la consigne. Dans l'hyperthermie, la consigne reste normale : la production ou l'apport de chaleur dépasse les pertes (DX.15, DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Mécanisme de la fièvre.
- **B** Cytokines pyrogènes de la fièvre.
- **D** Étape de la fièvre.
- **E** Étape de la fièvre.

③ **Perle** Les antipyrétiques inhibent la COX ; ils n'agissent donc pas dans l'hyperthermie.

④ **Source** Phase A §3 Physiopathologie · LOT_006 audité

Q85 SPE · Médecine intensive DX.15 · soluté et foie

✅ **E** — NaCl 0,9 %

① **Pourquoi c'est juste** Coup de chaleur : remplissage par NaCl 0,9 % ; le Ringer-lactate est contre-indiqué en cas de graves lésions hépatiques selon l'AIPS (DX.15). On surveille créatinine, potassium, CK, ASAT, ALAT, INR et plaquettes pendant 48 heures.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiqué en cas de graves lésions hépatiques (AIPS).
- **B** Il n'a pas d'effet volémique durable.
- **C** Le cristalloïde isotonique reste la référence.
- **D** Le remplissage est nécessaire.

③ **Perle** Mortalité en soins intensifs : 26,5 % dans la forme d'effort.

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_006 audité

Q86 EX DX.11 · qSOFA rassurant

✅ **D** — Mesurer le lactate et prélever des hémocultures

① **Pourquoi c'est juste** Un qSOFA à 0 ou 1 n'exclut pas le sepsis : la SSC 2021 déconseille le qSOFA comme seul outil de dépistage (DX.11). Frissons solennels et marbrures imposent lactate et hémocultures, avec réévaluation horaire.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le qSOFA est peu sensible ; il n'exclut pas le sepsis.
- **B** L'antipyrétique ne ferme aucune branche dangereuse.
- **C** Le SIRS seul ne pose ni n'exclut le sepsis.
- **E** On réévalue avant la décompensation, pas après.

③ **Perle** Les frissons solennels accompagnent la décharge de cytokines d'une bactériémie.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_006 audité

**Q87** **EX** **DX.2 · bactériurie sans symptôme**

✅ **D** — Pas d'antibiotique

① **Pourquoi c'est juste** La pyélonéphrite exige des signes systémiques ou une douleur lombaire avec une culture positive (DX.2). Une bactériurie asymptomatique seule ne pose pas le diagnostic.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une bactériurie asymptomatique ne se traite pas ici.
- **B** Aucun signe systémique.
- **C** Aucun signe d'atteinte rénale.
- **E** La répétition ne change pas l'absence de symptôme.

③ **Perle** Une bandelette positive ne dit pas si l'infection touche le rein ou la vessie.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_006 audité

**Q88** **EX** **DX.3 · hémocultures systématiques ?**

✅ **B** — Non : réservées au sepsis ou à l'immunodépression

① **Pourquoi c'est juste** Dans la cellulite simple, les hémocultures sont rarement positives : elles sont indiquées en cas de sepsis ou d'immunodépression (IDSA) (DX.3). Le diagnostic est clinique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le diagnostic est clinique.
- **C** Conduite de l'endocardite.
- **D** Elles sont rarement positives ; un résultat négatif n'exclut rien.
- **E** Il est lui aussi rarement positif.

③ **Perle** Une CRP normale n'exclut pas la cellulite.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_006 audité

Q89 EX DX.10 · enfant de 4 ans

✅ **D** — Lopéramide

① **Pourquoi c'est juste** Le lopéramide est interdit avant 6 ans (AIPS Imodium®) (DX.10). Chez l'adulte, il est aussi exclu en cas de sang dans les selles ou de fièvre élevée.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Traitement principal.
- **B** Antipyrétique possible en cas de besoin.
- **C** Mesure recommandée.
- **E** Elle protège l'intestin.

③ **Perle** Arrêter le lopéramide après 2 jours sans amélioration, ou dès constipation ou ballonnement.

④ **Source** Phase B DX.10 §13 · LOT_006 audité

Q90 EX DX.14 · examen du neutropénique

✅ **E** — Toucher rectal

① **Pourquoi c'est juste** Chez le neutropénique, le toucher rectal est contre-indiqué ; on inspecte la région périanale (DX.14).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Geste recommandé.
- **B** Recherche de mucite, utile.
- **C** Recherche d'un foyer, utile.
- **D** Recherche d'une pneumonie, utile.

③ **Perle** Hygiène des mains et soins de bouche font partie des mesures générales.

④ **Source** Phase B DX.14 §14 · LOT_006 audité

**Q91** **EX** **DX.14 · fièvre sous métamizole**

✅ **C** — Arrêter le métamizole et faire une formule sanguine

① **Pourquoi c'est juste** Le métamizole peut causer une agranulocytose, indépendante de la dose : fièvre ou angine imposent l'arrêt immédiat et une numération (DX.14). Neutrophiles < 0,5 G/L : neutropénie fébrile.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le médicament est la cause suspecte.
- **B** Fièvre et angine sous métamizole : agranulocytose à exclure d'abord.
- **D** Il ne répond pas au danger principal.
- **E** Traitement symptomatique inadapté.

③ **Perle** Novalgin® est réservé à la forte fièvre qui résiste aux autres mesures.

④ **Source** Phase A §11 Prise en charge · LOT_006 audité

**Q92** **EX** **DX.9 · dose de paracétamol**

✅ **C** — Ne pas dépasser 4 g/j, toutes sources comprises

① **Pourquoi c'est juste** Paracétamol chez l'adulte de plus de 40 kg : 500 à 1000 mg par prise, toutes les 4 à 8 h, maximum 4 g/j (AIPS Dafalgan®) (DX.9). Vérifier que les autres médicaments ne contiennent pas de paracétamol.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose maximale adulte : 4 g/j.
- **B** Intervalle de 4 à 8 h entre les prises.
- **D** Il n'apporte rien et ajoute un risque.
- **E** Dose maximale dépassée.

③ **Perle** L'antipyrétique vise le confort ; il ne traite pas la cause.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_006 audité

**Q93** **AP** **DX.9 · troisième trimestre**

✅ **E** — Ibuprofène

① **Pourquoi c'est juste** L'ibuprofène est contre-indiqué au 3e trimestre (AIPS Brufen®) ; dès la 20e semaine, risque d'oligohydramnios et d'insuffisance rénale néonatale (DX.9). Le paracétamol reste possible à la dose efficace la plus faible.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Utilisable en cas de nécessité, à la dose efficace la plus faible, le moins longtemps possible.
- **B** Possible en cas de nécessité absolue, sans ajustement de dose.
- **C** Possible si formellement indiquée ; seule la voie i.m. est contre-indiquée.
- **D** À utiliser avec la plus grande prudence, sans contre-indication formelle.

③ **Perle** Le métamizole est aussi contre-indiqué au 3e trimestre.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_006 audité

**Q94** **EX** **DX.13 · pas de souffle**

✅ **A** — L'absence de souffle n'exclut pas l'endocardite

① **Pourquoi c'est juste** Un souffle absent et une ETT négative n'excluent pas l'endocardite (DX.13). Prothèse valvulaire et fièvre : trois paires d'hémocultures, puis échocardiographie, ETO si l'ETT est normale.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le souffle peut manquer, surtout au début ou dans la régurgitation aiguë.
- **C** Les hémocultures se prélèvent avant l'antibiotique.
- **D** Il en faut trois paires.
- **E** Une ETT négative n'exclut pas.

③ **Perle** Une hémoculture isolée à germe peu typique ne remplit pas le critère majeur.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_006 audité

**Q95** **AP** **DX.2 · co-trimoxazole et rein**

✅ **A** — Bactrim® forte ne doit pas être utilisé

① **Pourquoi c'est juste** Sous 15 mL/min, l'AIPS interdit l'emploi de Bactrim® forte, qui expose aussi à l'hyperkaliémie (DX.2). On choisit une alternative selon l'antibiogramme.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Contre-indiqué sous 15 mL/min.
- **C** L'AIPS interdit son emploi sous 15 mL/min.
- **D** Risque d'hyperkaliémie, sans lever l'interdiction.
- **E** Cure inadaptée à une pyélonéphrite.

③ **Perle** Co-amoxicilline : 625 mg toutes les 12 h de 10 à 30 mL/min.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_006 audité

**Q96** **EX** **DX.1 · clairance 25 mL/min**

✅ **D** — 625 mg toutes les 12 heures

① **Pourquoi c'est juste** Amoxicilline-acide clavulanique (AIPS) : de 10 à 30 mL/min, 625 mg toutes les 12 heures ; sous 10 mL/min, 625 mg toutes les 24 heures ; pas de 2 × 1000 mg sous 30 mL/min (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Pas de 2 × 1000 mg sous 30 mL/min.
- **B** Dose maximale de la fonction rénale normale.
- **C** Dose sans insuffisance rénale.
- **E** Dose d'une clairance < 10 mL/min.

③ **Perle** Réévaluer à 48–72 h et chercher une complication si pas d'amélioration.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_006 audité

Q97 EX DX.4 · médicament fébrigène

✅ **A** — Arrêter ou remplacer le médicament suspect

① **Pourquoi c'est juste** Un médicament fébrigène explique une fièvre sans foyer ; la fièvre cède quelques jours après l'arrêt (DX.4). On demande les médicaments des 8 dernières semaines et l'on arrête ou remplace le suspect.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Il masquerait la cause.
- **C** Elle masquerait la cause.
- **D** Le critère de durée de la FUO n'est pas rempli et une cause simple est à tester.
- **E** Un médicament des 8 dernières semaines peut être fébrigène.

③ **Perle** Dans la FUO, on arrête ou remplace tous les médicaments, même pris depuis des années.

④ **Source** Phase A §5 Anamnèse · LOT_006 audité

Q98 SPE · Rhumatologie DX.5 · méthotrexate

✅ **B** — Une fois par semaine

① **Pourquoi c'est juste** En rhumatologie, le méthotrexate se prend une fois par semaine : 7,5 mg au début, maximum habituel 25 mg par semaine (AIPS) ; il est contre-indiqué pendant la grossesse (DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Erreur dangereuse : surdosage.
- **C** Erreur dangereuse : surdosage.
- **D** Rythme incorrect.
- **E** Rythme incorrect.

③ **Perle** La corticothérapie se réduit sous le seuil de Cushing (5 à 7,5 mg/j de prednisone).

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_006 audité

**Q99** **AP** **DX.15 · dantrolène**

✅ **A** — Le refroidissement rapide reste le seul traitement

① **Pourquoi c'est juste** Le paracétamol et le dantrolène ne traitent pas le coup de chaleur : aucun traitement spécifique n'existe hors refroidissement rapide (DX.15). Une hyperthermie après anesthésie récente fait discuter une hyperthermie maligne.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Aucun effet démontré dans le coup de chaleur.
- **C** La consigne est normale ; il charge le foie.
- **D** Aucun traitement ne remplace le refroidissement.
- **E** Les AINS n'ont aucune place ici.

③ **Perle** Agitation, frissons ou convulsions : midazolam titré.

④ **Source** Phase B DX.15 §13 · LOT_006 audité

**Q100** **AP** **DX.12 · sortie après pénicilline**

✅ **B** — Une prophylaxie d'éradication du portage

① **Pourquoi c'est juste** La pénicilline n'éradique pas le méningocoque du nasopharynx : le patient reçoit une prophylaxie avant la sortie (BAG 2025) (DX.12). Le cas est déclaré dans les 24 heures et les contacts étroits reçoivent la prophylaxie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La pénicilline n'éradique pas le germe du nasopharynx.
- **C** Aucune indication systématique.
- **D** Aucune indication.
- **E** Aucune indication.

③ **Perle** Séquelles chez 10 à 20 % des survivants : contrôler l'audition.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_006 audité